

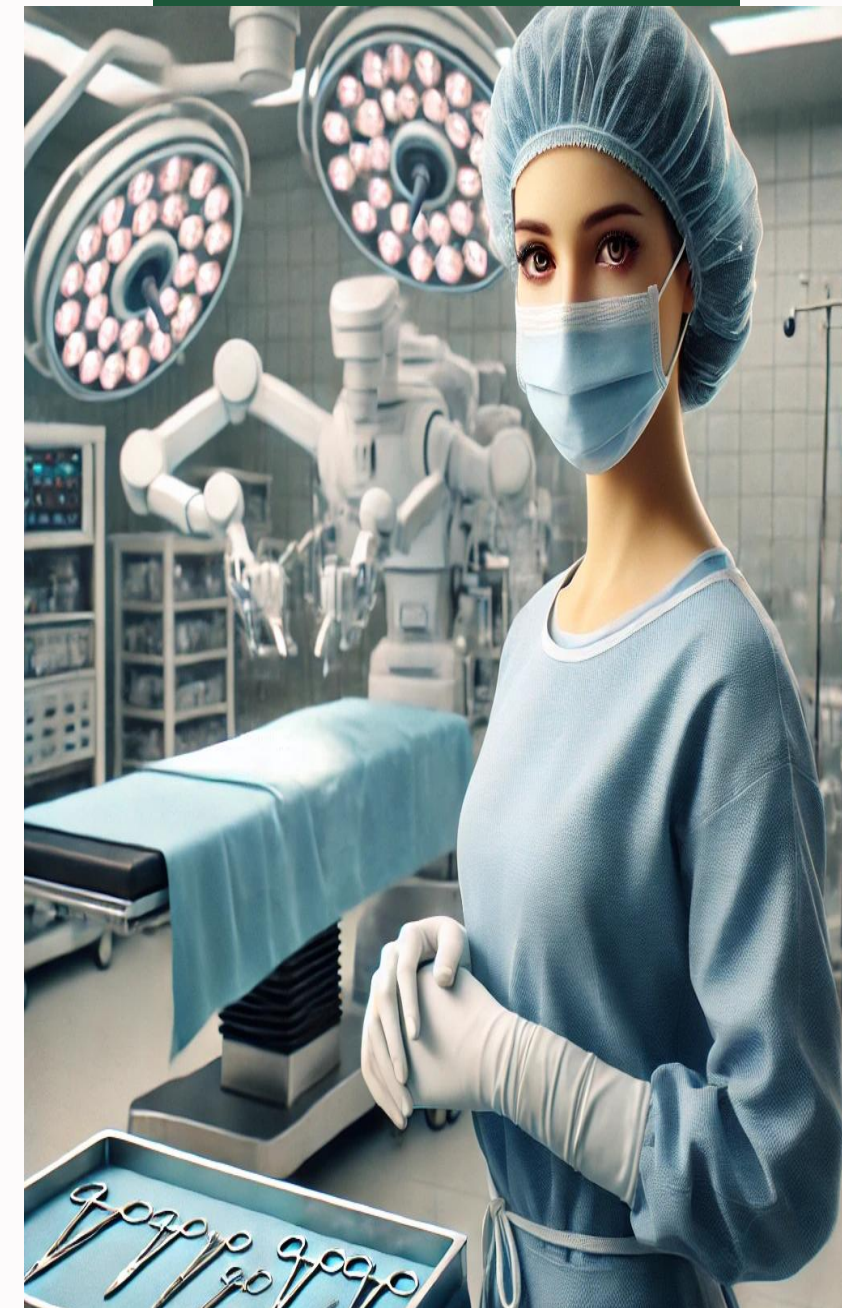


Perioperative
Nursing Division

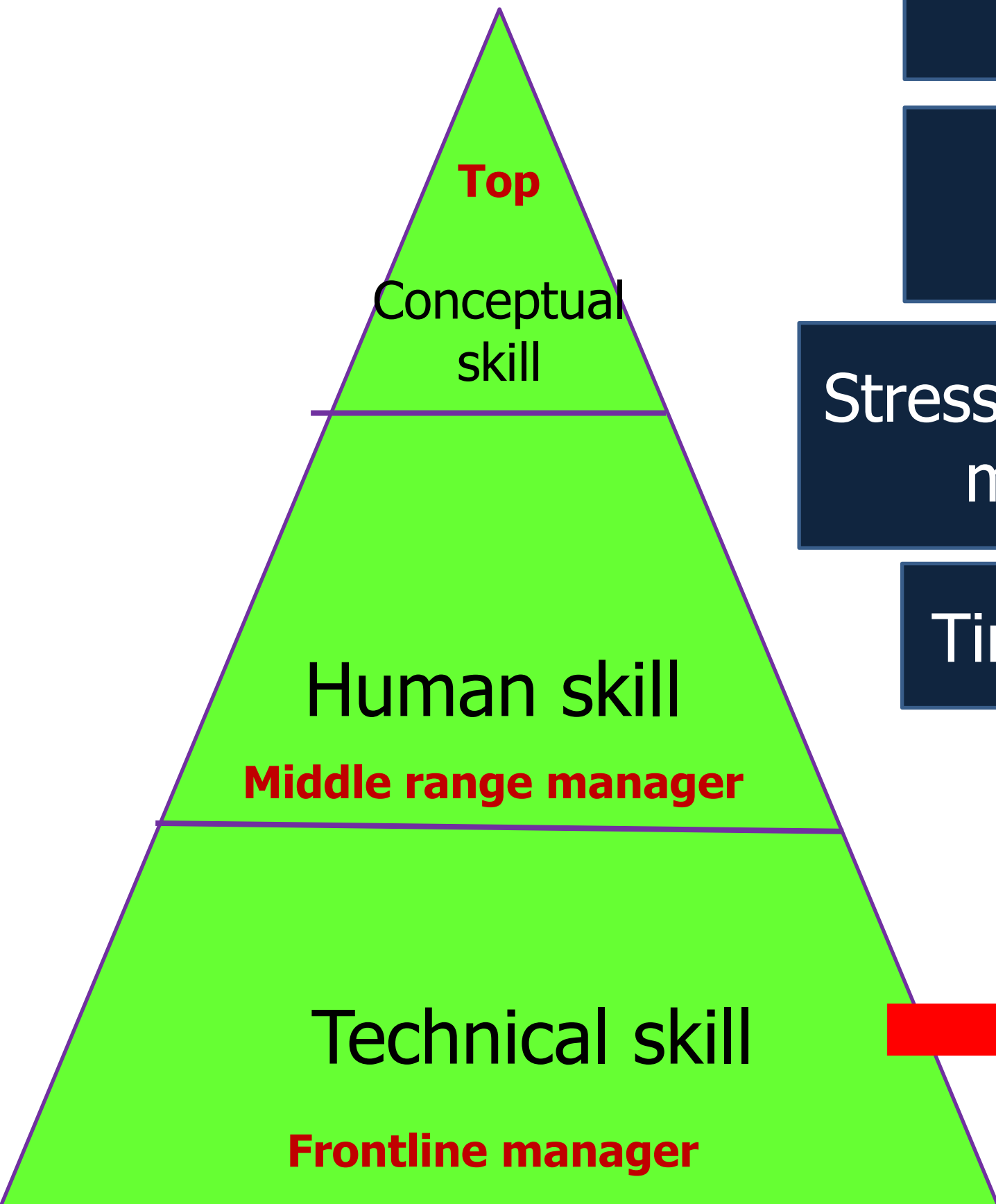
Perioperative Nursing Division

9 October 2026
8:45-10:00 am.

Wanvimol Kongsuwan, PhD, RN, T-CNOR
Head of Perioperative Nursing Division
Nursing Department, Siriraj hospital



Managerial Competency



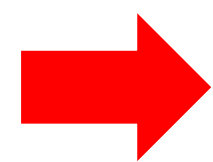
Theory of Management

- Planning
- Organizing
- Commanding & staffing
- Coordinating
- Controlling

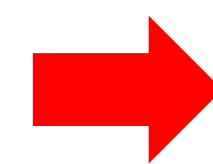




พ.ศ. 2446 ตึกผ่าตัดหลังที่ 2
ตึกแปดเหลี่ยม



พ.ศ. 2469 ตึกผ่าตัดหลังที่ 3
ศาลาศัลยกรรม



พ.ศ. 2531 ตึกผ่าตัดหลังที่ 4
ตึกสยามินทร์



พ.ศ. 2436 ตึกผ่าตัดหลังแรก
โรงกระโจม
ตั้งอยู่ระหว่างตึกตรีเพชร
กับตึกจุฑาธุช

หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัด โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ ถึง ปัจจุบัน

 นางสาวพรรณิ จันทวงศ์ (๒๔๙๘ - ๒๕๒๐)	 นางจุฑาภรณ์ ภมรสุด (๒๕๒๐ - ๒๕๓๒)	 นางสาวทอง จันทวงศ์ (๒๕๓๒ - ๒๕๓๘)	 นางปราณี บุรินทร์โกษณ์ (๒๕๓๘ - ๒๕๔๓)	 นางสาวสมิต เสงี่ยมรัตน์ (๒๕๔๓ - ๒๕๕๒)
 นางพณีย์ ศรีศักดิ์ (๒๕๕๒ - ๒๕๕๔)	 นางสาววิไลพร บุญฤกษ์ (๒๕๕๔ - ๒๕๕๕)	 นางสาวนงนุช ปรีชาคุณ (๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)	 นางดารณี พิพัฒน์กุลชัย (๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)	 นางสาวจุฑามาศ คำแพร่ (๒๕๕๙ - ปัจจุบัน)

พ.ศ. 2520

แผนกการพยาบาลผ่าตัด แยกออกจากแผนกศัลยกรรม
นางจุฑาภรณ์ ภมรสุด หัวหน้าพยาบาลประจำแผนกผ่าตัด

พ.ศ. 2535

งานการพยาบาลผ่าตัด
นางปราณี บุรินทร์โกษณ์
หัวหน้างานการพยาบาลผ่าตัดคนแรก



น.ส.กรองแก้ว ไส้ธรรมกุล
พ.ศ. 2562-2568



ดร.วรรณวิมล คงสุวรรณ
พ.ศ. 2568-ปัจจุบัน



Faculty of Medicine Siriraj hospital

Faculty of Nursing

Siriraj Hospital

Department

Department

Siriraj Integrated Center
of Excellence (SiCOE)
CTP/ERAS/DSC/ODS Program

Nursing Department

Others Nursing
Division



Perioperative nursing Division

- **11** Perioperative care units (**62 OR**)
- **3** Pre and Post Anesthesia care units
- **6** Special Examination & Follow up units

- Department of Surgery
- Department of Orthopedic surgery
- Department of ENT
- Department of Ophthalmic
- Department of Anesthesiology
- Department of Radiology
- Department of Transfusion Medicine
- Department of Pathology
- Department of Clinical Pathology

- Department of Surgery Nursing

- CSS Division
- Department of Pharmacy
- Patient Transfer Service
- Laundry & linen Division
- Medical Record Division
- Social Welfare Division
- Centre for Nosocomial Infection Control
- Occupational Health Division
- Facilities and Environmental management Division
- Medical Gas System Division
- Maintenance Division



ChatGPT

Top 5

1) **Mayo Clinic**

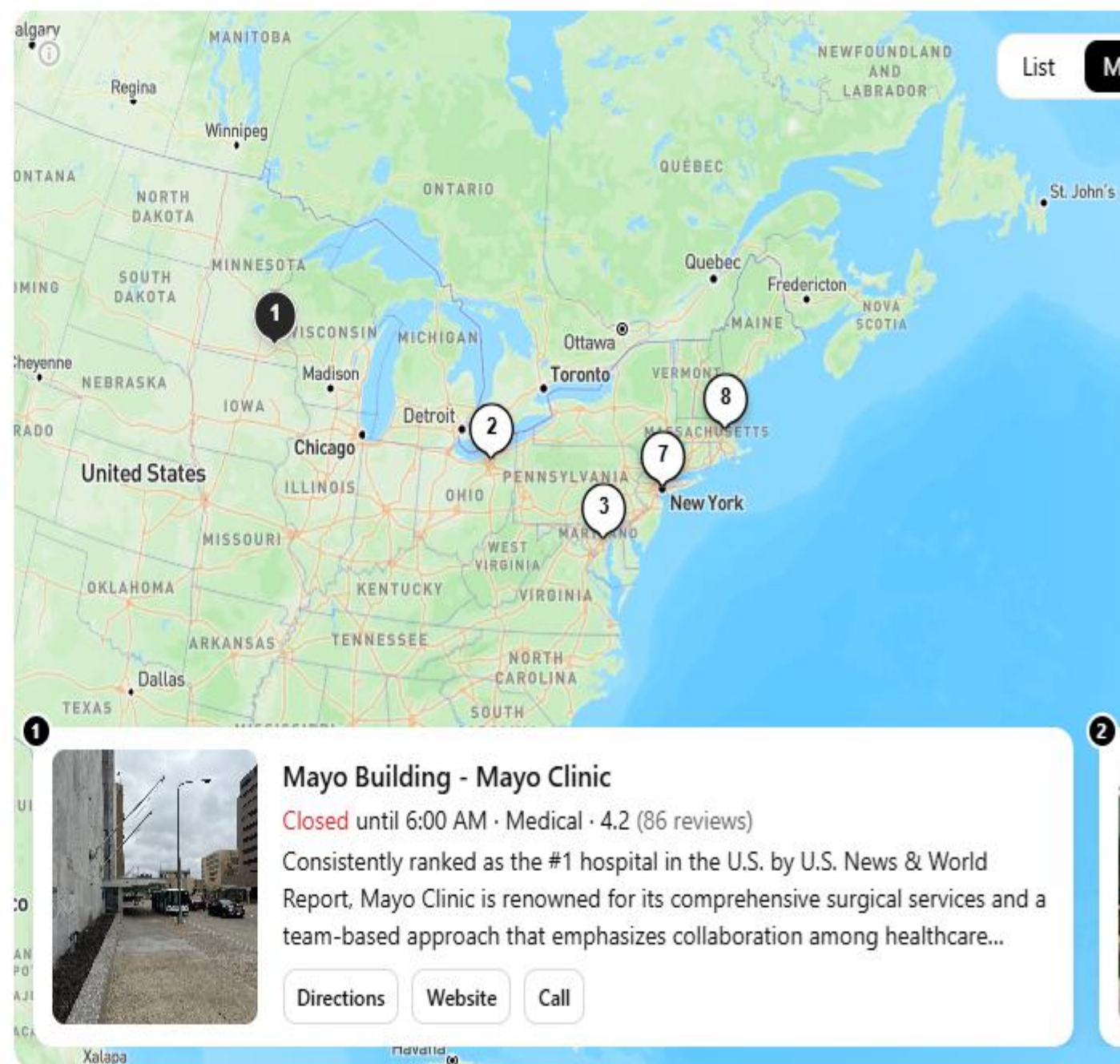
2) Cleveland Clinic

3) John Hopkin

4) NYU Longne health

5) Stanford hospital

In the United States, several hospitals are renowned for their exceptional surgical care and the collaborative efforts between surgeons and nursing staff. Here are some of the top institutions recognized for their excellence:



These institutions are distinguished not only by their surgical capabilities but also by their commitment to fostering a collaborative environment among healthcare professionals, ensuring comprehensive

Operating Room (OR) nurses may choose to work at Mayo Clinic for several reasons:

- Reputation and Prestige:** Mayo Clinic is consistently ranked as one of the top hospitals in the world, particularly for its comprehensive patient care and high standards. Many nurses are attracted to work in such a well-regarded institution to be part of a team that upholds excellence in healthcare.
- Cutting-Edge Technology and Practices:** Mayo Clinic is known for its advanced medical technology and innovative surgical techniques. OR nurses may choose Mayo Clinic to work in an environment that allows them to be involved in state-of-the-art procedures, participate in groundbreaking research, and continually develop their skills.
- Professional Development and Education:** Mayo Clinic offers numerous opportunities for continued education, training, and career advancement. Nurses may appreciate the emphasis on professional development, including specialized programs and leadership training.
- Collaborative Work Environment:** The Mayo Clinic is known for its team-based approach to patient care. OR nurses may be attracted to the opportunity to work closely with multidisciplinary teams of surgeons, anesthesiologists, and other healthcare professionals, fostering a collaborative environment.
- Job Stability and Benefits:** Mayo Clinic offers competitive salaries, comprehensive benefits, and a strong emphasis on work-life balance. These factors may make it a desirable choice for OR nurses looking for long-term job security and support for their well-being.
- Commitment to Patient-Centered Care:** Mayo Clinic's strong commitment to patient-centered care and holistic treatment approaches can be a significant draw for nurses who are passionate about providing high-quality, compassionate care to patients.



A safe and healthy work environment

Obj.1
Comprehensive offerings

Obj.2
Professional growth & Development

Obj.3
Nursing Quality & Research

Professional development opportunities

Recognition for achievement

Obj.5
Shared Governance

Obj.4
Data driven

Strong leadership

Competitive wages

20
Unit

Professional Nursing Management Model



Applied from: ANCC Pathway to Excellence Framework



Structural of Operative Building

Consideration

1) Zoning

- Transition area-Semi restricted-Restricted-Disposal area

- Operating Room Classification

2) Traffic flow : Patient, Surgical instrument

3) Air Ventilation system

4) Support system

- Fire

- Medical gas

- Radiation

- Infection control

- water quality

- Communication system: Intercom, telephone, Intranet, wifi, etc.

5) Inventory control system

Cluster Combination, peripheral and central corridor style



SCALE 1:150

Room size

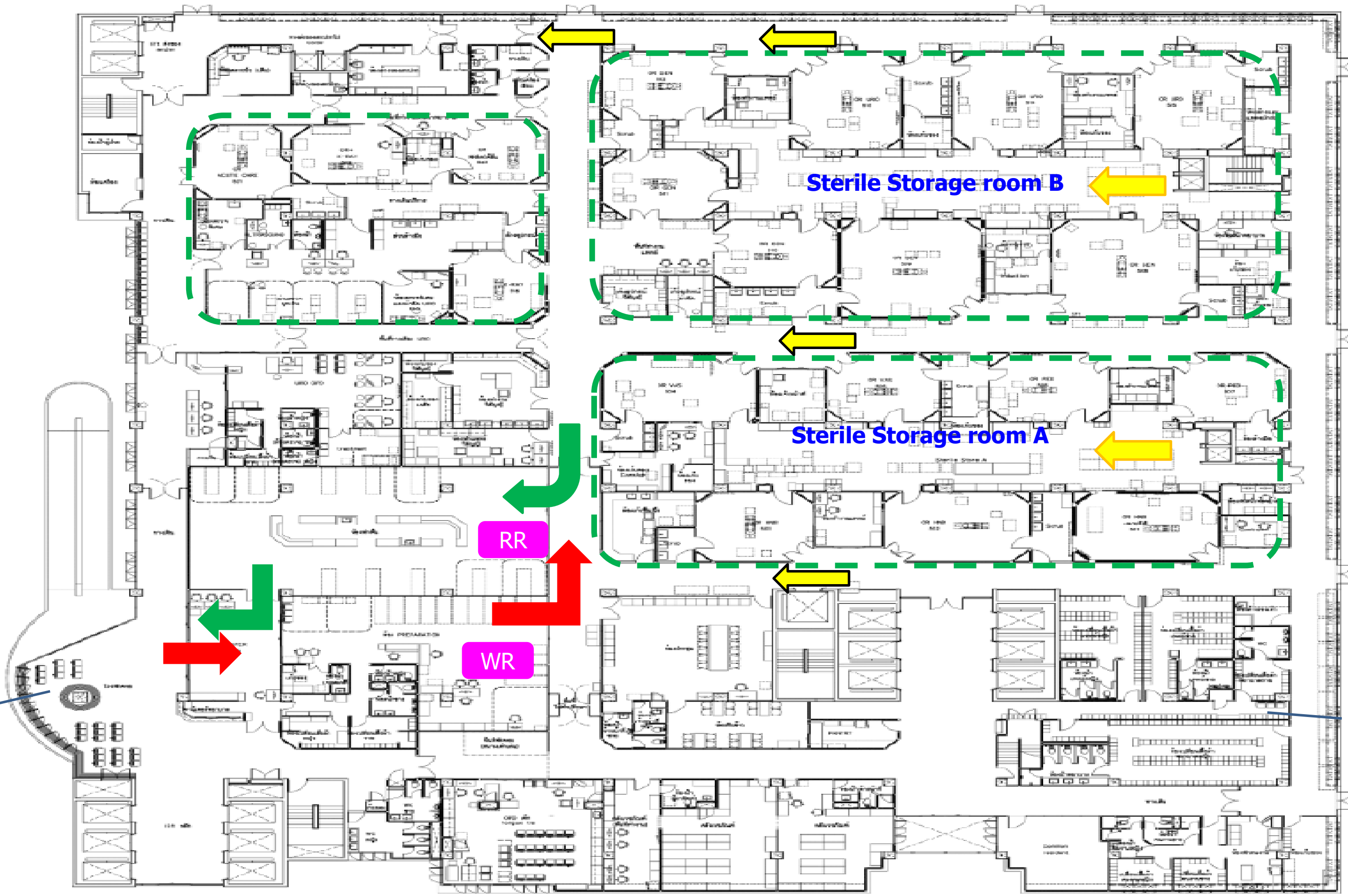
S=36m²

M=48m²

L=64 m²

← Patient in
← Patient out

Holding area

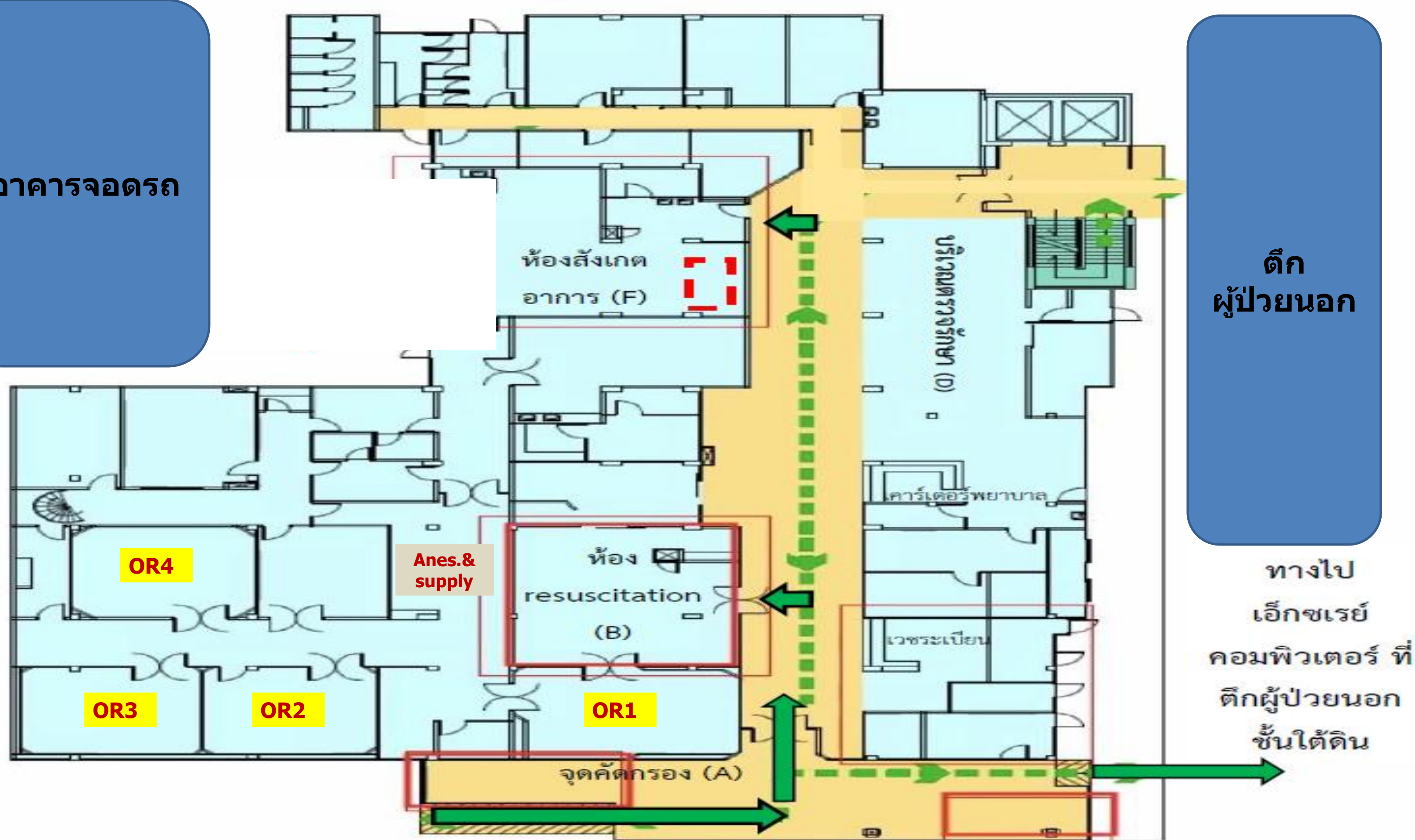


← Sterile Instrument
← Dirty Instrument

Transition zone

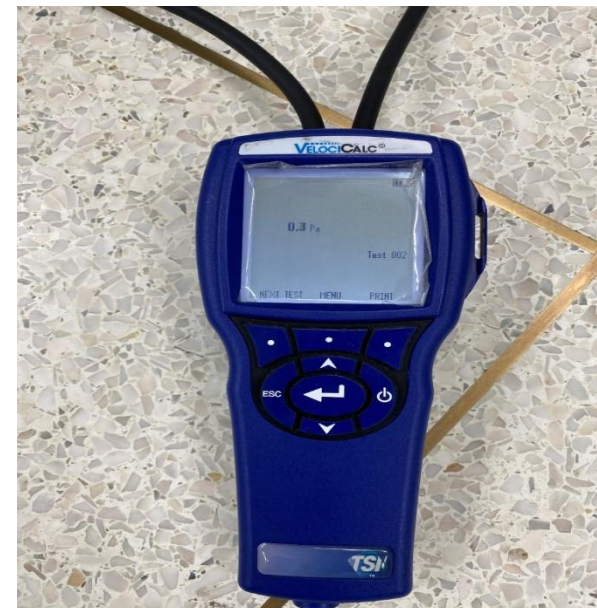
อาคารจอดรถ

ตึก
ผู้ป่วยนอก



รถมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งผู้บาดเจ็บ

-
- A white GSD water meter with a digital display. The display shows '0.000' and '0.000'. Below the display, it says 'GSD water meter'. The meter has buttons for 'Prog', 'Set', and 'Test'.



ตารางตรวจเช็คระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

ประเภทห้องผ่าตัด

งานการพยาบาลผ่าตัด/ หน่วย

อาคาร ชั้น ห้อง

ว/ด/ป	พารามิเตอร์				
	แรงดัน (Pa)	อุณหภูมิ(°C)	ความชื้นสัมพัทธ์(%RH)	ลงชื่อผู้ตรวจ	หมายเหตุ ระบุวันที่แจ้งซ่อม
	ไม่มีการแสดงค่าแรงดันในห้องผ่าตัด มีการตรวจวัดจากงานอาชีวอนามัยทุกปี				

ประเภทหอผู้ป่วย/หน่วยตรวจ	พารามิเตอร์ Parameter	ค่ามาตรฐาน/คำแนะนำอ้างอิง Standard/Guideline	ค่าใช้งาน Useable	ค่าเฝ้าระวัง Surveillance	ค่าเตือน Alarm
ห้องผ่าตัด	แรงดัน(Pa)	≥+ 2.5	+7.5	+5	<+2.5
	อุณหภูมิ(°C)	20-24	23±2	25-26	>26
	ความชื้นสัมพัทธ์(%RH)	20-60	50±10	NR	>60
การแจ้งซ่อม		หมายเลขติดต่อ		การดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุง	
ซ่อมเร่งด่วน(ค่าเฝ้าระวัง)		T.97955		ซ่อมภายใน 3 วัน	
ซ่อมฉุกเฉิน(ค่าแจ้งเตือน)		T.99339		ซ่อมภายใน 24 ชั่วโมง	





รายงาน

การตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบกรองอากาศ

ห้องผ่าตัด
โรงพยาบาลศิริราช

โดย
งานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลศิริราช

ตารางสรุปผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพการทำงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศห้องผ่าตัด ตึกสยามินทร์ ชั้น 4

จุดที่ตรวจวัด	แรงดันอากาศ (Pa)	อัตราการแลกเปลี่ยน อากาศ	อุณหภูมิ (°C)	ความชื้นสัมพัทธ์ (%RH)
ค่ามาตรฐาน/แนะนำ	> + 2.5	> 20	20-24	30-60
1. OR 419	+ 3.1	28	20.1	54
2. OR 420	+ 3.6	33	20.0	56
3. OR 421	+ 3.2	30	21.0	52

ตารางแสดง Air Changes per hour (ACH) and time in minutes required for removal efficiencies
of 99.9% of airborne contaminants*

Room	Air Change per Hour (ACH) ที่ตรวจวัดได้	Minutes required for removal efficiencies of 99.9% of airborne contaminate
1. ห้องผ่าตัด 419	28	17 นาที
2. ห้องผ่าตัด 420	33	14 นาที
3. ห้องผ่าตัด 421	30	14 นาที



The image shows a medical gas control panel with five digital displays. A pink sticky note is attached to the top of the panel. The displays show the following values:

- Oxygen: 57
- Nitrous Oxide: 55
- Surgical Air: 88
- Vacuum: 5
- Medical Air: 37

The panel also features a 'POWER' button and a 'TEST' button. The text 'Ohio' is visible on the left side of the panel.



- ❖ Oxygen (O_2)
- ❖ Nitrous oxide (N_2O)
- ❖ Medical Air
- ❖ Surgical Air
- ❖ (Compression Air)
- ❖ Vacuum system
- ❖ Exhaust system

ตารางตรวจเช็คระบบแก๊สทางการแพทย์ สำหรับห้องผ่าตัด
 งานการพยาบาลผ่าตัด/ หน่วย..... ห้อง.....

ตรวจเช็ค 1 ครั้งต่อสัปดาห์

[illegible]

✓ หมายถึง ปกติ X หมายถึง ผิดปกติ N/A หมายถึง ไม่มีให้ตรวจสอบ

เมื่อพบความผิดปกติ แจ้งงานระบบแก๊สทางการแพทย์ โทร.9-7220

การตรวจใช้ระบบแก้สทางการแพทย์เบื้องต้น โดยบุคลากรในหน่วยงาน ดังนี้

1) ตรวจสอบสภาพ **zone valve** ที่ผนังภายนอกห้องผ่าตัด

- มีแผ่นพลาสติกปิด zone valve สมบูรณ์ไม่ชำรุด
- valve และ หน้าปิดแรงดันแก๊สไม่ชำรุด valve เปิดไปทางเดียวกัน
- ไม่พบเสียงลมฟุ้งออกมาจาก valve หรือ ท่อแก๊ส

2) ตรวจสอบ **Inlet-outlet (WALL)** ที่ผนังภายในห้องผ่าตัด

- ลักษณะภายนอกไม่มีรอยร้าว แตก ขำรุด
- ใช้มือกด Inlet-outlet ได้ เมื่อปล่อยมือ Inlet-outlet ดัดกลับเข้าที่เดิม ไม่ค้าง
- ไม่พบเสียงลมพุ่งออกมาจาก Inlet-outlet
- Vacuum มีแรงดูด ใช้งานได้จริง

หมายเหตุ* Inlet-outlet จากเพดาน บุคลากรทางภาควิชาวิศวกรรมผู้รับผิดชอบ

Update 16 ตุลาคม 2566



Fire Safety System

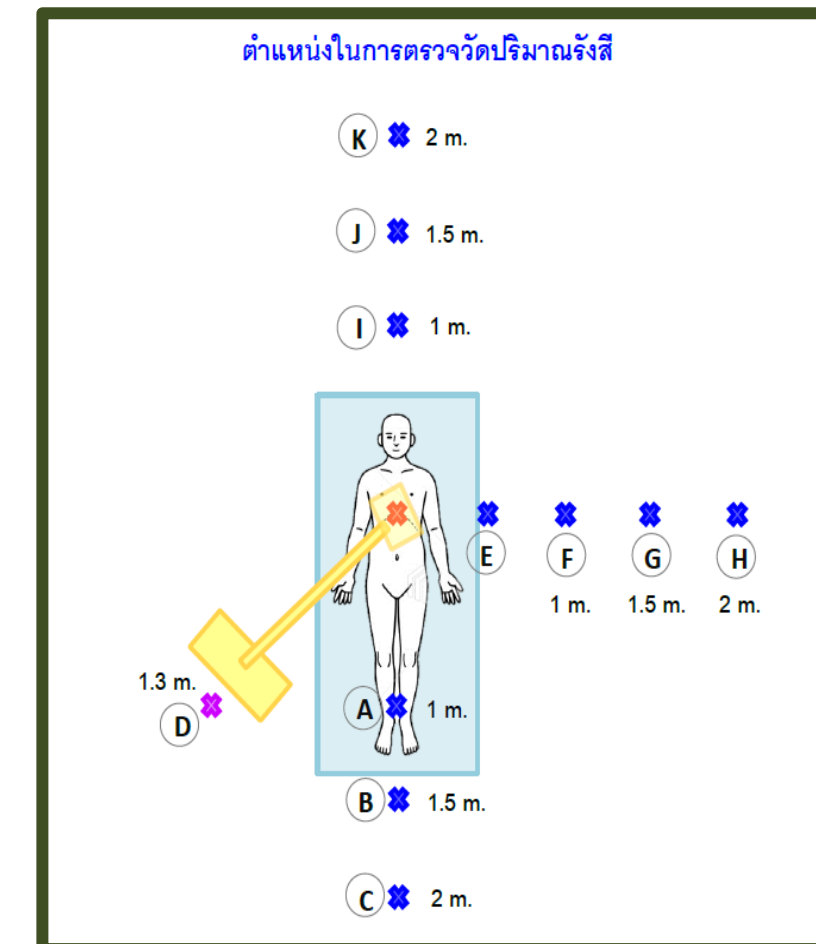
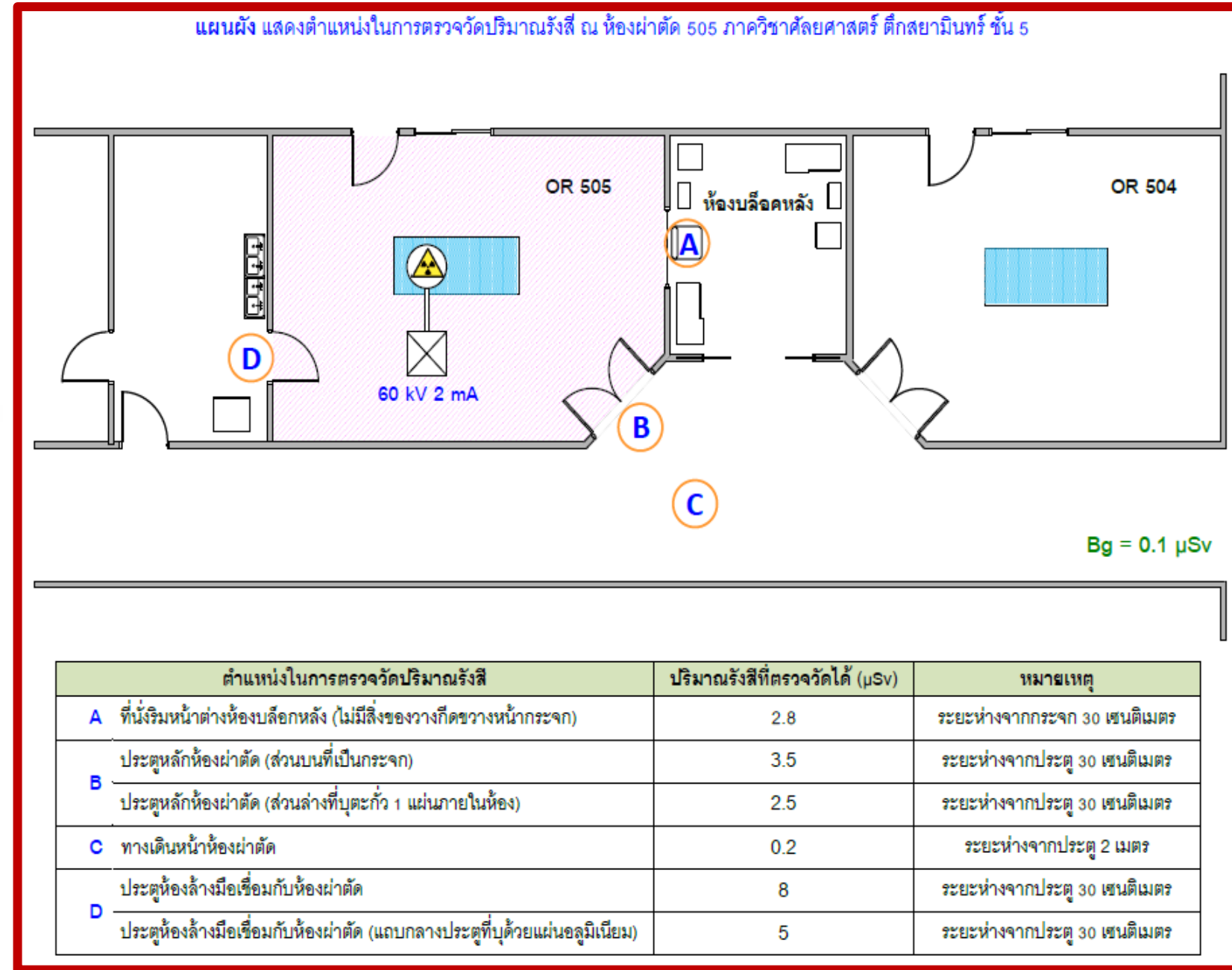
- ❖ Location of med gases shut-offs and electrical controls
- ❖ Location and activation of fire alarm system
- ❖ Use of fire equipment
- ❖ Methods for rescue & escape



Radiation Safety System



- ตรวจสอบเครื่องกำหนดรังสีตามรอบปีละ 1 ครั้ง
- ติดตามปริมาณรังสีสะสมในร่างกาย จากตัว OSL ประจำตัวของบุคลากร การติดใช้งานถูกต้อง
- ตรวจสอบห้องผ่าตัดที่มีการใช้เครื่องฉายรังสี
- ความรู้ ความเข้าใจ และ การปฏิบัติงานของบุคลากร กับเครื่องกำเนิดรังสีประเภทต่างๆ ที่ใช้ทางการแพทย์





Hyper Light Disinfection Robot

- เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ชนิด C
- แสงคลื่น 254 นาโนเมตร
- การกระจาย 3x3 เมตร
- มีแถบ Fast check
- การทำลายเชื้อขึ้นอยู่กับ ระยะทาง, เวลา และพื้นผิวสัมผัสแสง
- ไม่มีแสงตกค้าง เข้าทำงานต่อได้ทันที



การสำรวจความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (Occupational hazards) งานการพยาบาลผ่าตัด



IC

ENV

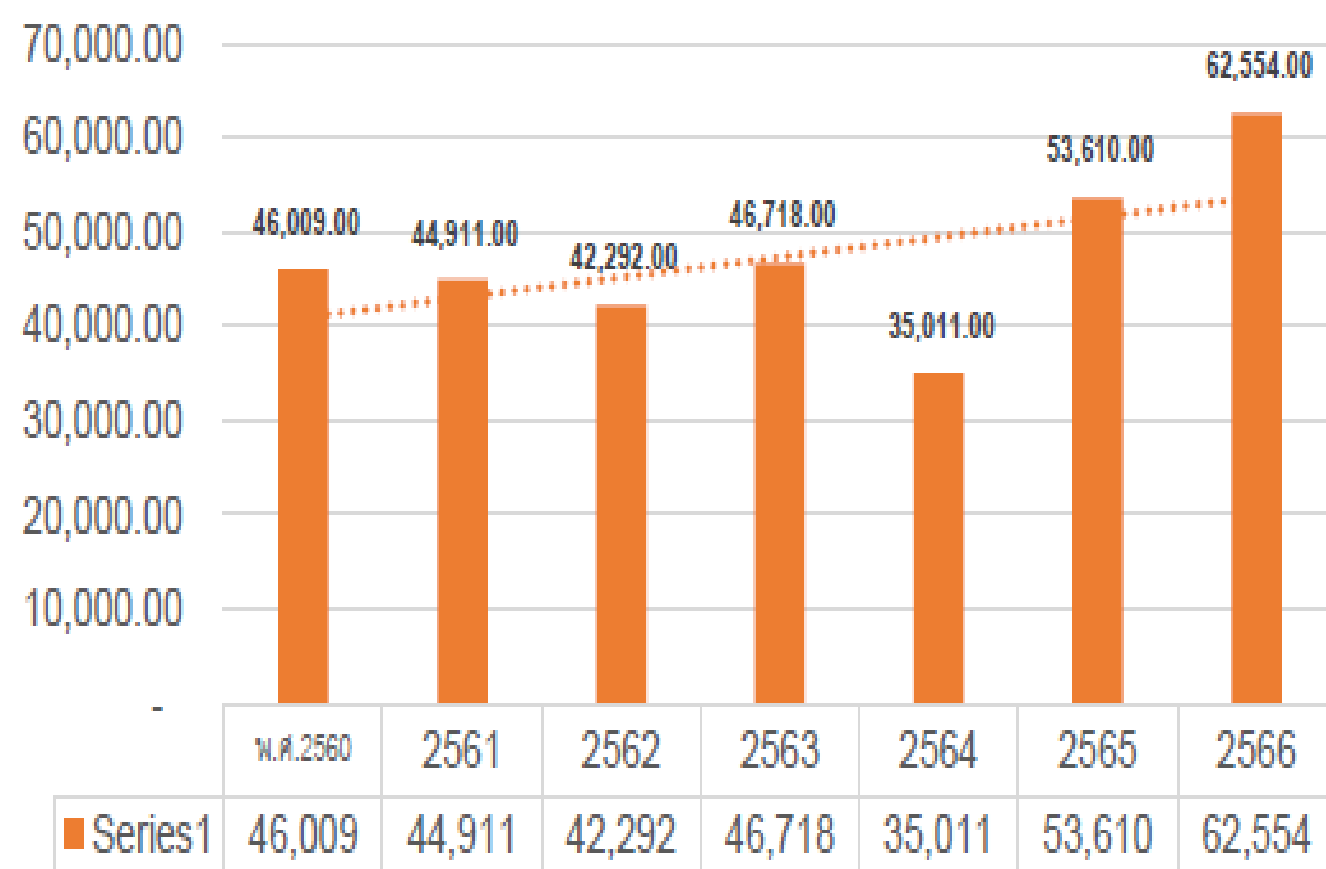
Occupational infections					Exposure to Radiation		Exposure to hazardous chemicals		
1) TB	2) COVID-19 / โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจอื่นๆ เช่น SARS, หวัดนก	3) Hepatitis B, HIV	4) VRE, CRE, Hepe (contact precaution)	5) อื่นๆ (โปรดระบุในหมายเหตุ)	6) X - ray	7) UV light	8) ยาเคมีบำบัด	9) สารเคมีอื่นๆ เช่น Cidex, formalin, H ₂ O ₂	10) อื่นๆ (โปรดระบุในหมายเหตุ)

อัคคีภัย

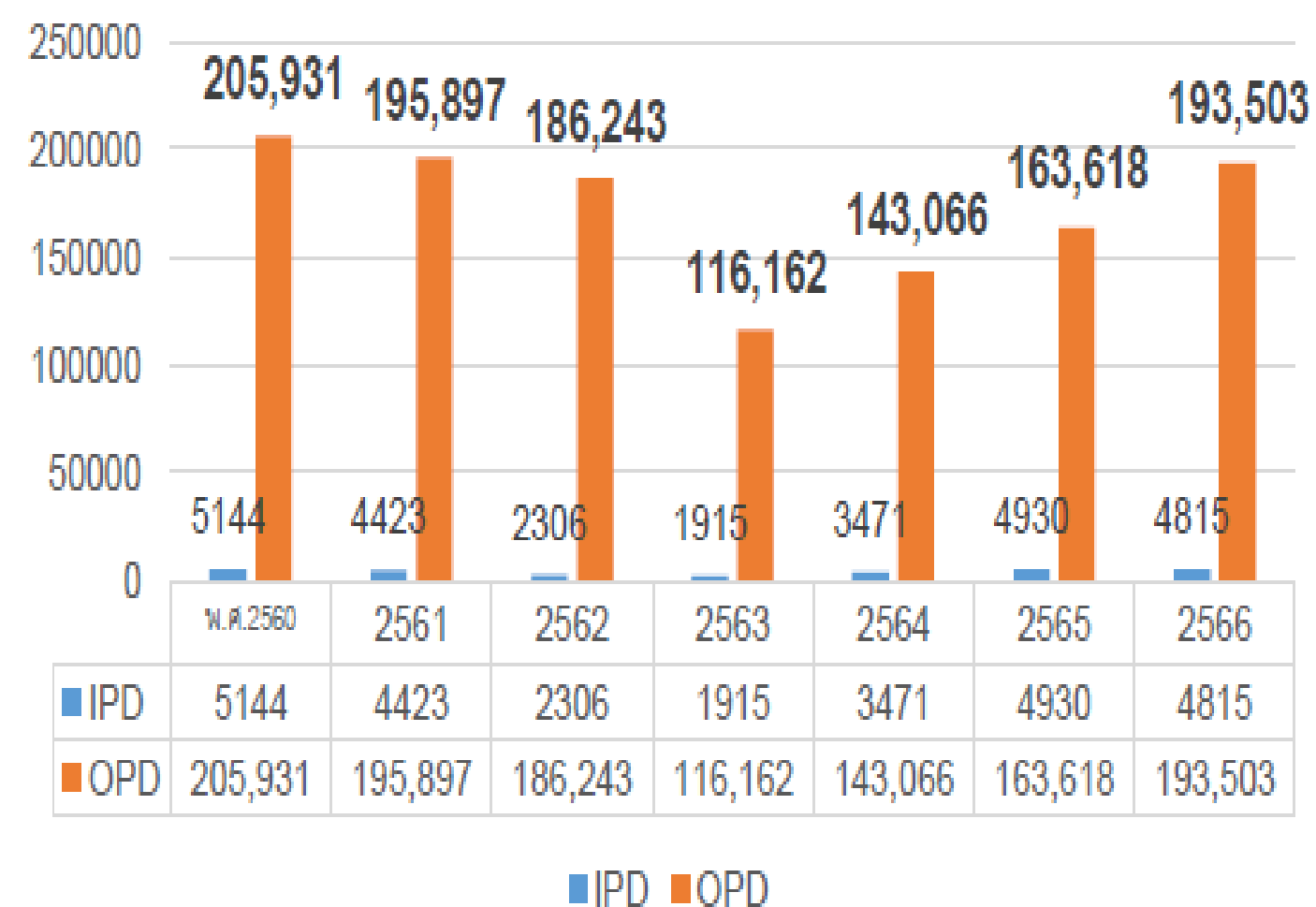
ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ (Ergonomics)	Occupational injuries				Risks in ambient work environment	Violence and harassment:
11) ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม เช่น ท่านั่ง ท่ายืน ท่ายกของหรือยกตัวผู้ป่วย จัดท่าผู้ป่วยทำให้เกิดการบาดเจ็บ (ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่)	12) Sharp injury (เข็ม/ของมีคม)	13) กระแสไฟฟ้า ลัดวงจร	14) เพลิงไหม้	15) อื่นๆ (โปรดระบุในหมายเหตุ)	16) อันตรายจากการระบายอากาศ อุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง เสียงดัง ไม่ได้มาตรฐาน	17) ความเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายหรือการใช้ความรุนแรงทางวาจา ร่างกาย ทางเพศ

ระดับความเสี่ยง ประเมินจากระยะเวลาหรือความถี่ที่สัมผัสความเสี่ยง	แปลผล
ไม่มีความเสี่ยง/ไม่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
สัมผัสความเสี่ยงน้อยกว่า 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ (สัมผัสครั้งละน้อยกว่า 2 ชม. / น้อยกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์)	เสียงต่ำ
สัมผัสความเสี่ยง 8-25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (สัมผัสครั้งละ 2-5 ชั่วโมง/ 3-5 วันใน 1 สัปดาห์)	เสียงปานกลาง
สัมผัสความเสี่ยงมากกว่า 25 ชั่วโมง/สัปดาห์ (สัมผัสครั้งละ มากกว่า 5 ชั่วโมง/ มากกว่า 3 วันใน 1 สัปดาห์)	เสียงสูง
หมายเหตุ** อาจพิจารณาร่วมกับความรุนแรงของผลกระทบได้คะ	

จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดที่มารับบริการ ผ่าตัด



จำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจ



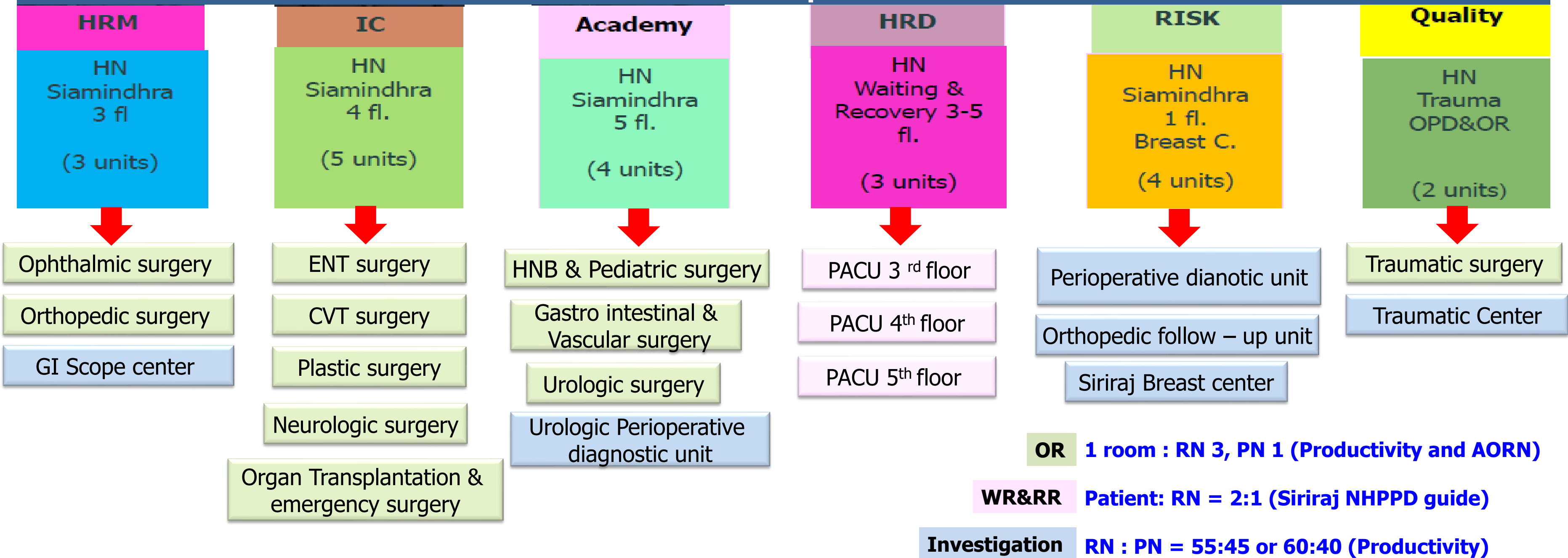
Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Director of Nursing Department

Head of Perioperative Nursing Division

6 Nurse Supervisors



Total 681 : 323 Registered nurses/ 238 Practical nurses/ 19 Clerk/ 84 House keeper

October, 2026



มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

ข้อมูลบุคลากรภาพรวม

ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม 2568

ภาควิชา/หน่วยงาน

ฝ่ายการพยาบาล

งาน/สาขา

งานการพยาบาลผ่าตัด

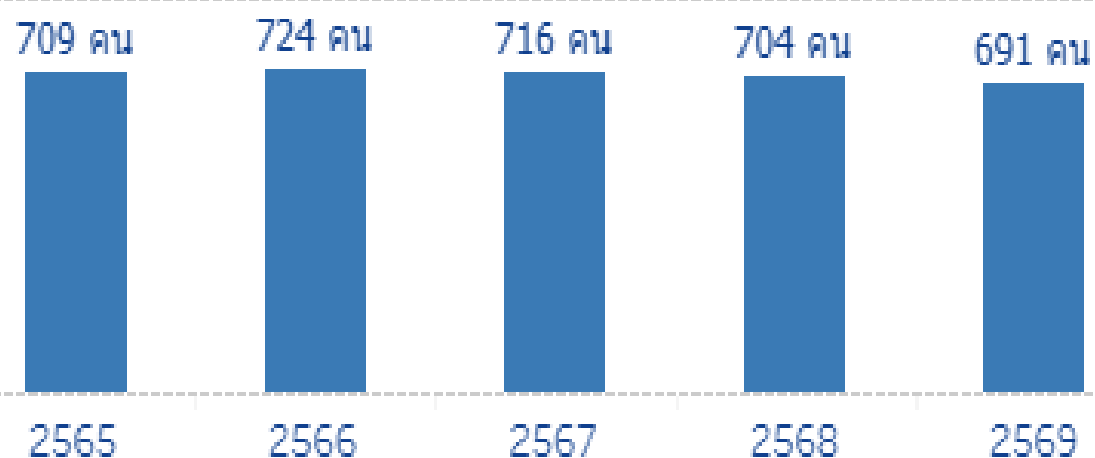
หน่วยงานย่อย

(All)

ปีงบประมาณ

(All)

จำนวนบุคลากร



สายงาน

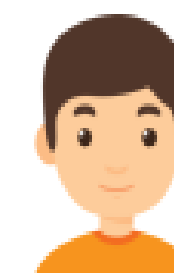
สายสนับสนุนวิชาชีพเฉพาะ

50.507%

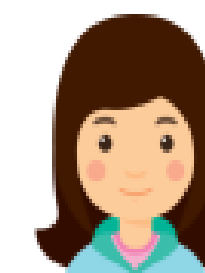
สายสนับสนุนทั่วไป

49.493%

เพศ

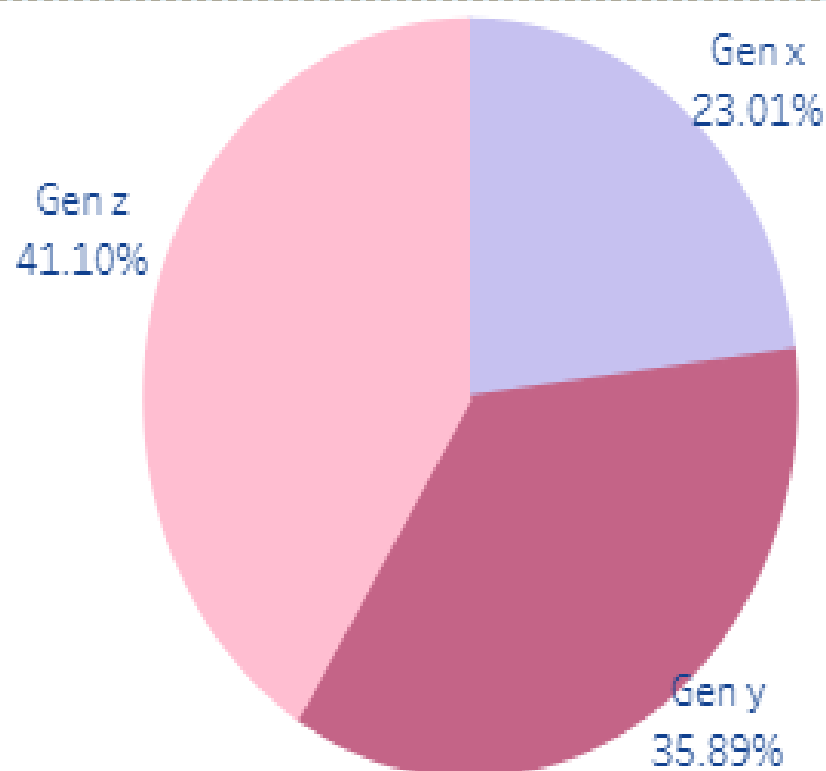


ชาย
15.34%

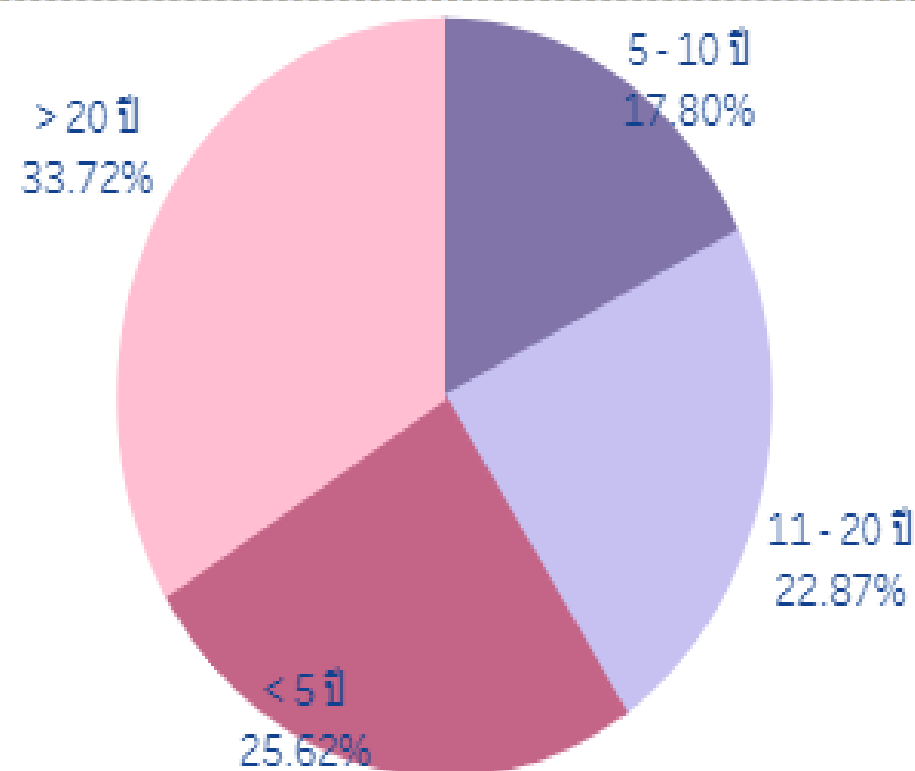


หญิง
84.66%

ช่วงอายุบุคลากร



ช่วงอายุงาน



วุฒิการศึกษา

ต่ำกว่า ปริญญาตรี

15.48%

ประกาศนียบัตร

30.68%

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

50.36%

ปริญญาโท หรือเทียบเท่า

3.04%

ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า

0.43%



Norm



It is not merely about regulations, established standards of practice, guidelines
but about values, competencies, professionalism, and a culture of care that guides perioperative nursing practice.

Ethical practice

Patient right, Advocacy & Trust

Patient safety first

Standardization

Professional competency

Technical & Non Technical skills

Team collaboration

Interprofessional communication & Leadership

What is Perioperative nursing?



the **specialized nursing practice** that supports patients undergoing surgical or invasive procedure, across three phase:

- ❖ **Preoperative:** Patient assessment, preparation and education to **minimize risks**.
- ❖ **Intraoperative:** Maintaining sterile fields, direct assistance during surgery, monitoring vital sign, and **safeguarding patient safety**.
- ❖ **Postoperative:** Monitoring recovery, **preventing complications**, supporting rehabilitation and self care management, hand off for continuity of care

Outcome

- helping patients feel less anxious and coping with stress before the operation
- Provide assistance to the surgical team during the operation
- Assist the patient after surgery to provide the best care to ensure that patient needs both pre and post surgery.

A variety of perioperative nurse role



- Scrub nurse
- Circulating nurse
- Registered Nurse First Assistance (RNFA)
- Nurse Manager
- Nurse Educator
- Case Coordinator / Navigator
- Advanced practice nurse (APN)
or Clinical nurse specialists (CNS)
- Certified Perioperative Nurse (CNOR)
or Certified Specialized Nurse of Perioperative nursing



Phases of Perioperative Nursing care



Pre-operative

begins with the patient's decision to have surgery, ends with entry into the operating room



Intra-operative

begins with the entry into the operating room and ends with admission to the recovery room



Post – operative

begins with admission to recovery room, and ends with discharge from care



Patient privacy shall be provided at all time

Responsibilities of Operating Room Nurse



Pre-operative phase

- Patient assessment
 - Read and interpret lab results
- Physical problem
- Emotional aspects
- Understanding of surgery and consent
- Legal requirements for chart completion
- Peri-operative education for patient & family

Responsibilities of Operating Room Nurse



Intra-operative phase

- Provide for quiet environment during induction
- Assist during intubation
- Maintain and control aseptic technique
- Position patient safety
- ***Prevent of all risk during surgery***
- Provide all supplies, equipment, to team during surgery
- Safe operation of equipment
- Document events, patient care given
- Provide for a safe transfer to recovery room

Responsibilities of Operating Room Nurse



Post-operative phase

- Patient assessment : A-B-C, wound & drain, ...
- Monitoring and Maintain 5 physical parameters
Activity-Respiratory-Circulation-Consciousness-Pain
- Nursing care during intermediated recovery period
- Document events, patient care given
- Provide for a safe transfer to ward/ICU/ Home



ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช

Department of Nursing Siriraj Hospital



พยาบาลศิริราชเป็นอย่างไร ?

3 in 1

(Excellence nursing service+ Professional development + Research)

Leadership





Quality & Safety

Risk mitigation &
Continuous Quality
Improvement



Effectiveness & Efficiency

Resource utilization &
Waste management



Staff Capacity & Capability

Team engagement
Physical & Psychological
safety



Strategy

Logic Model

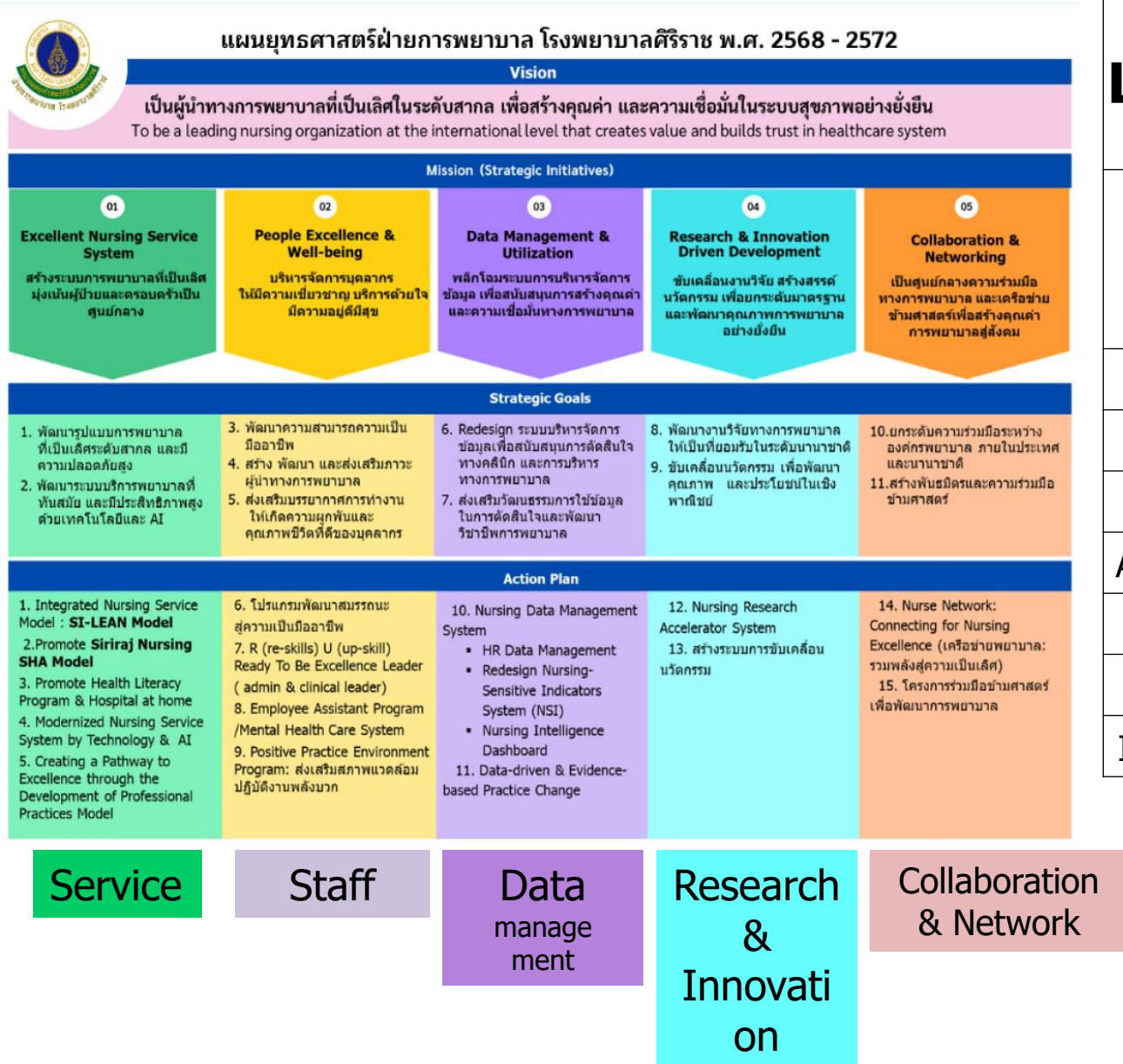
Performance Agreement



กำหนดทิศทางขององค์กร

ติดตามผลการดำเนินงาน KPI

ประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล



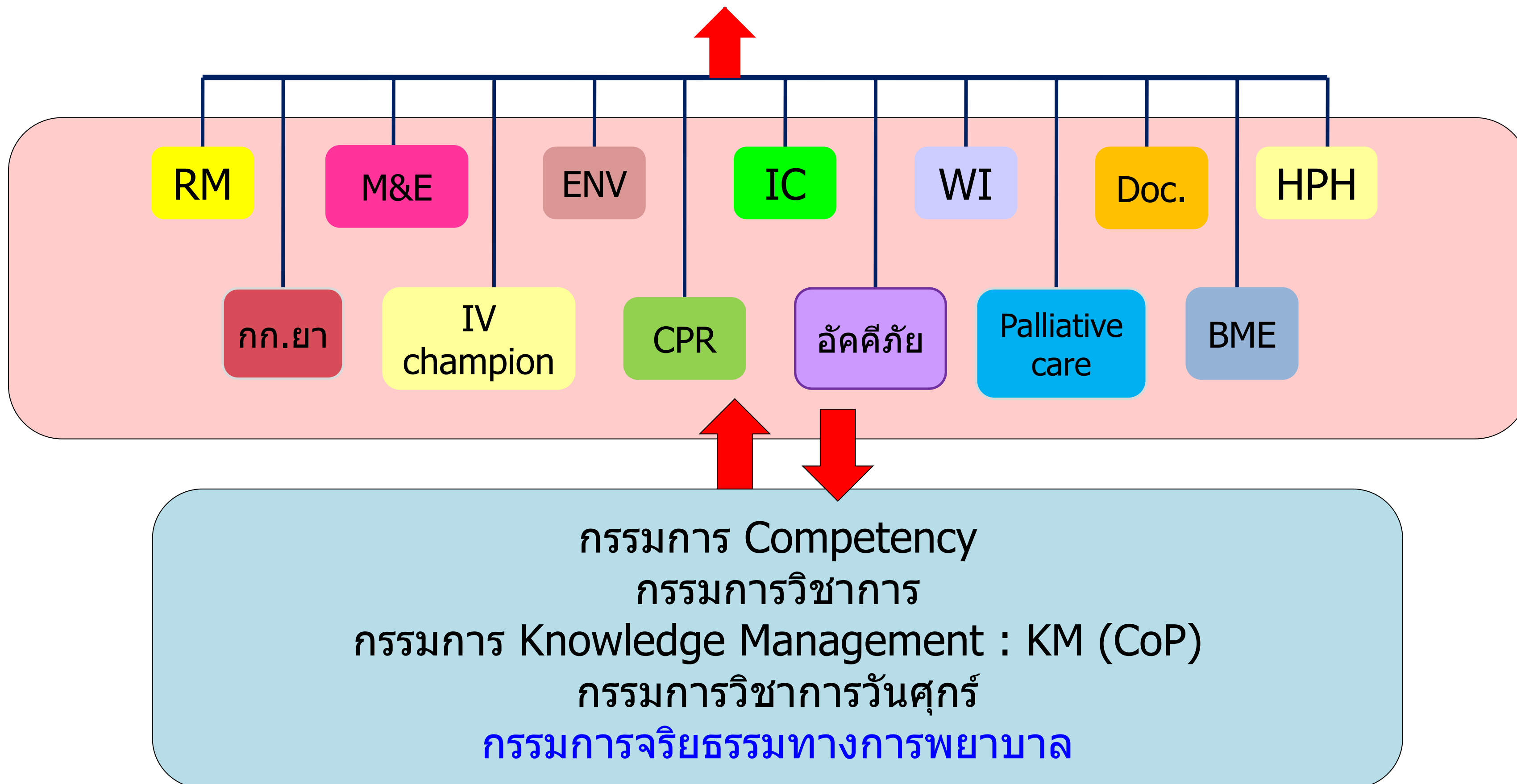
Logic Model ฝ่ายการพยาบาลฯ

	บริการ พยาบาล	HRM & HRE	HRD	วิจัยและ นวัตกรรม
หนง.				
HRM				
HRD				
Academic				
RM				
QM				
IC & ENV				

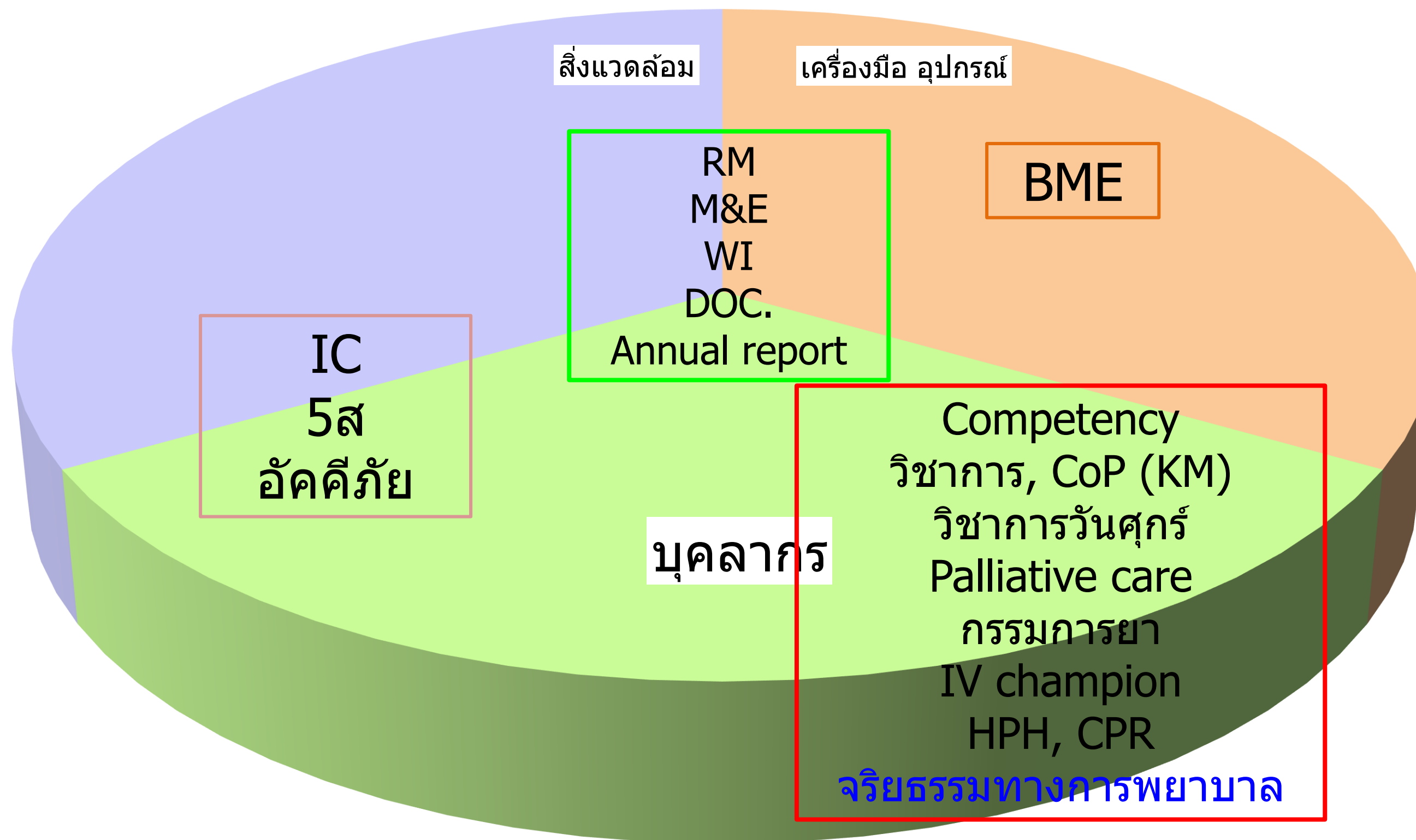
ภาระงาน	KPI PA ปี 2569
ภารกิจที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์คณะฯ / ฝ่ายการพยาบาลฯ (25%)	
1. ทบทวน และจัดทำแผนกลยุทธ์ประจำปี	1. ร้อยละความสำเร็จของการนำนโยบาย/แผนงานลงสู่การปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนด
2. สร้างและพัฒนาระบบบริการพยาบาลระดับเหนือตติยะภูมิด้วยมาตรฐานสากล	2. ร้อยละความสำเร็จ / ความก้าวหน้าตามแผนเฉพาะกลุ่มโรคที่กำหนด (ฝ่ายฯ กำหนดกลุ่มโรค)
3. สื่อสาร ถ่ายทอด มอบหมายงาน เชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	3. ร้อยละความสำเร็จของการนำ SiLEAN ลงสู่การปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด
ภารกิจหลักของตำแหน่งงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ (50%)	
4. การบริหารจัดการด้านบริการพยาบาล	4. ร้อยละความคิดเห็นของบุคลากรต่อความสามารถ (Leadership Ability) การเป็นผู้นำทางการพยาบาล (จาก PPE)
	5. ร้อยละของตัวชี้วัดการบริการพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์ (WPI)
	6. อัตราการบรรลุเป้าหมาย 3P safety goal ของฝ่ายฯ
	7. อัตราความก้าวหน้าตามแผนดำเนินการด้านจริยธรรมทางการแพทย์/ SHA (OPD:ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ ESB, Caring)
	8.1 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (IPD : Top Box) หรือ
	8.2 อัตราความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (OPD : Top Box)
5. อนุรักษ์บุคลากรทางการแพทย์	9. อัตราความพึงพอใจของบุคลากร
	10. อัตราความผูกพันของบุคลากร
	11. ร้อยละการดำเนินการตามแผนส่งเสริม positive practice environment เป็นไปตามที่กำหนด Pilot เครื่องมือวัด PPE
	12. อัตราการลาออกของบุคลากรทางการแพทย์ที่มีขีดความสามารถสูง (Talent Staff)
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย (20%)	
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง	13. อัตราบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนที่กำหนด -Level 5 plus (Nurse coordinator/Nurse educator/Research Nurse/Informatic nurse) -Successor (ด้านบริหาร & ด้าน Clinic) -ชำนาญการ / เชี่ยวชาญ/ APN
	14. ร้อยละการดำเนินการตามแผนพัฒนา Competency base training เป็นไปตามแผนที่กำหนด (เป็นแผนปิด gap ตาม IDP) ล้อยกับข้อ 13
7. โครงการที่ได้รับมอบหมาย (ตามแผนยุทธฝ่ายฯ)	15. ร้อยละของความสำเร็จตามแผน (แผนงานเฉพาะแต่ละบุคคล)
8. เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	16. จำนวน งานวิจัย / งานวิเคราะห์ / งานสังเคราะห์ / CNPG/ SiCTT/ ตำราวิชาการ / คู่มือทางการแพทย์/ บทความทางวิชาการ/นวัตกรรมที่ Impact และมีการขยายผลในงาน ฯลฯ
ภารกิจเพื่อส่วนรวม (5%)	
9. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ฝ่ายการพยาบาลฯ คณะฯ และองค์กรวิชาชีพ ตามที่ได้รับมอบหมาย	17. อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อส่วนรวมที่ได้รับมอบหมาย

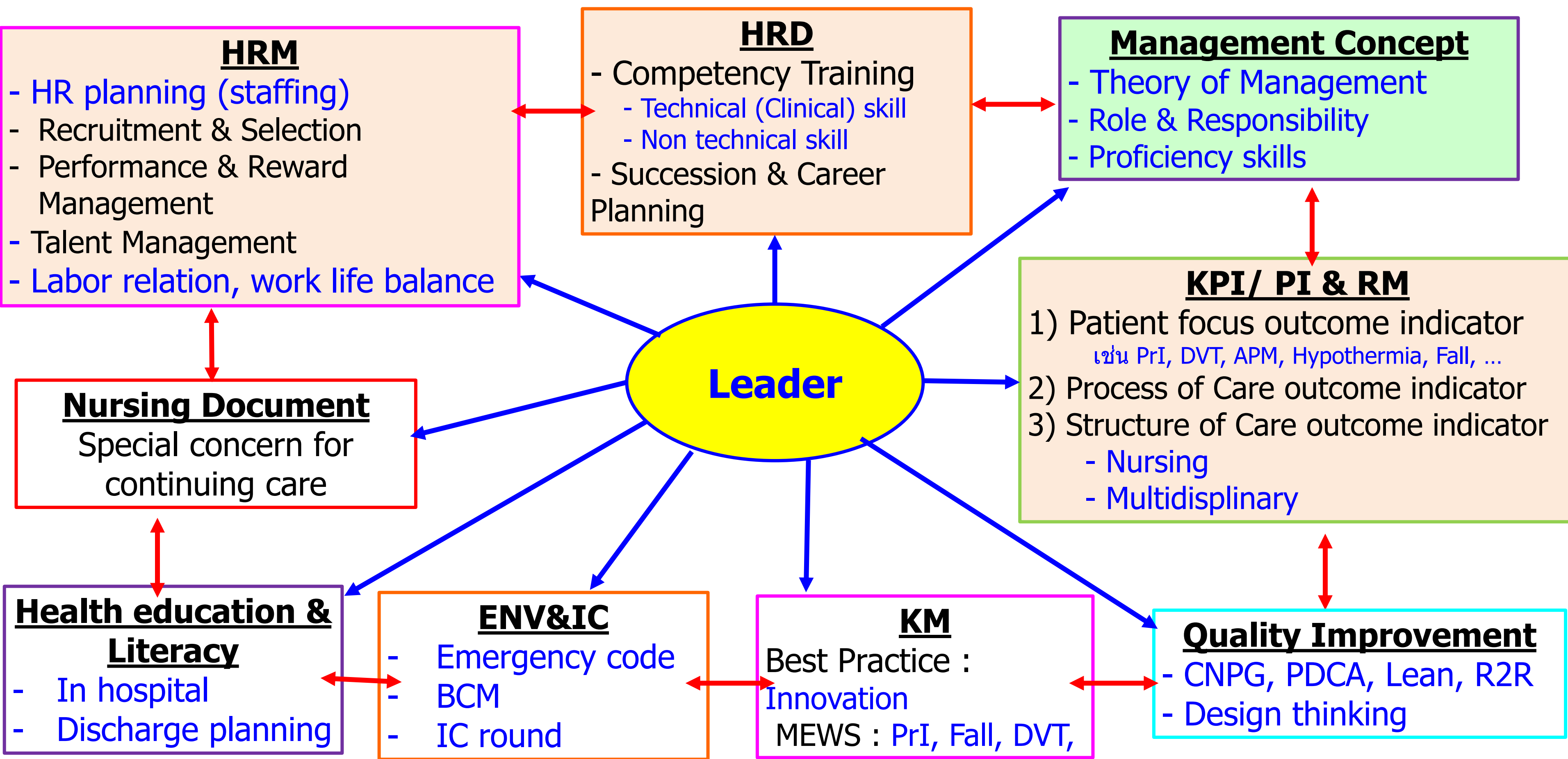


18 Quality Team

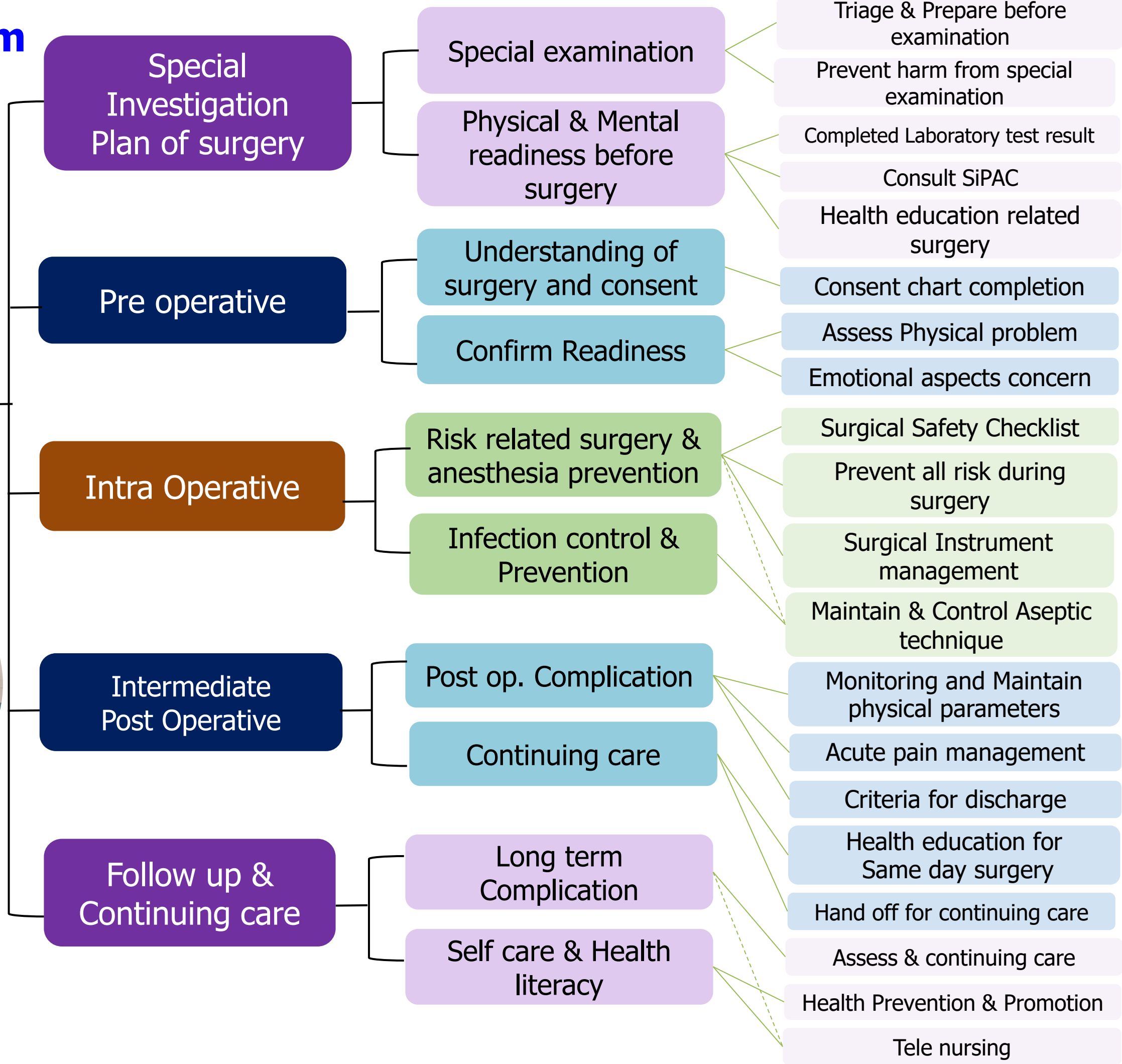


กรรมการประจำหน่วยงาน





Driver Diagram



Patient focus outcome

- Wrong site, patient, surgery
- Retained surgical items
- Injury related positioning
- Pain & **Comfort score**
- Fall
- Hypothermia
- Blood transfusion error
- SSI
- Medication error
- Triage error
- Deficient knowledge & Skills
- Patient satisfaction
- **Impaired gas exchange**
- **Ineffective thermoregulation**
- **Impaired urinary elimination**
- **PrI - Healing pattern**
- **Anxiety & Ineffective coping (Patient & Nurse)**

Process of care

- Patient Identification
- SSC
- Hygienic & Surgical hand cleaning
- Compliance rate of use guideline: PrI, Fall, Stroke fast track, ...
- Acute pain management
- Nursing documentation
- Health education





Outcome Indicators

Reflect patient outcomes that are determined to be nursing sensitive because they depend on the quantity or quality of nursing care outcome.

	Patient focus outcome Indicator	Target	ปี พ.ศ.		
			2565	2566	2567
1	Triage error (above level E)	0 ครั้ง			
1	Patient Fall with injury (above level D)	≤ 0.1 ครั้ง/ 1000 visit			
2	Medication error (above level D)	0 ครั้ง			
3	Patient education (OPD case)	≥ 95%			
4	Patient Satisfaction (OPD Top box)	>65%			
5	Wrong site, patient, surgery	0 ครั้ง			
6	Retained surgical Items (Significant)	0 ครั้ง			
7	Pressure related injury stage 2 Healing pattern	0 ครั้ง			

Process Indicators

methods of patient assessment and nursing interventions and competency assessment.
Nurses job satisfaction

	Nursing process Indicator	Target	ปี พ.ศ.		
			2565	2566	2567
1	Maintenance of skin integrity (MEWS: PrI prevention)	>90%			
2	Compliance rate of guideline: Triage error	0 ครั้ง			
3	Acute pain management (Pain score < 3 before discharge)	100%			
4	Hygienic (20 units) and Surgical Hand cleaning (11 units)	≥60% />95%			
5	Nursing documentation	≥ 95%			
6	Competency assessment	ตามแผน			

[illegible][illegible][illegible]

	ประเภท 	RN:PN	Staff : Patient
OPD	ตรวจรักษาเฉพาะโรค (BC, OPD Tr, สม.104)	55:45	1:30
	ตรวจกิจกรรมซับซ้อน (GI scope, สม.1)	60:40	1:15
OR	Minor surgery (LA)	50:50	1.5:1
	Major surgery	60:40	4:1 (2.5:1)
	Special Major surgery	70:30	5:1 (4:1)
RR	General Anesthesia	60:40	1:1
	Regional Anesthesia	55:45	1:2
	Local Anesthesia	50:50	1:3

<https://www.tnmc.or.th> ISBN: 978-616-8012-34-5

the supply of nursing staff, the skill level of nursing staff, equipment, education and certification levels of nursing staff

Structural Indicators

<https://www.americansentinel.edu/blog/2011/11/02/what-are-nursing-sensitive-quality-indicators-anyway/>

The Practice Environment Scale of the Nursing Work index

- 1) Nurse participant in hospital affairs
- 2) Nursing foundations for quality of care
- 3) Nurse manager ability, leadership and support of nursing
- 4) Staffing and Resource Adequacy**
- 5) Nurse Physician relation

the National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI)

Organizational-focused structure Indicator			Target		ปี พ.ศ.		
					2565	2566	
1	Number staffing ratio and staff levels		ตามมาตรฐาน		✓	✓	✓
2	Staff Qualification (Education and Certification)		ตามแผน		✓	✓	✓
3	Productivity		85-115 %	OPD	112.7	119.5	121.2
				OR	95.7	102.4	98.7
				RR	92.9	110.9	111.1
	<u>Nurse focus outcome Indicator</u>						
1	Sharp injury and blood exposure		0 ครั้ง		22	13	26
2	Physical injury		0 ครั้ง		2	2	9
3	Staff engagement (Emometer)		≥ 80%		79.78	81.65	81.40
4	Staff satisfaction (Emometer)		≥ 75%		75.90	71.05	77.84
5	Turnover rate		< 5%		6.3% 20/317	8.0% 26/323	3.7% 12/319
6	Nurse burnout/ Worn out/ Well being/ ProQOL		ยังไม่มี		เริ่มปี 2568		
7	PES-NMI & Nurse autonomy*		ยังไม่มี		เริ่มปี 2568		





ประเภทผู้ป่วยในห้องผ่าตัด / ชม.การพยาบาลต่อราย (NHPP)

ประเภทผู้ป่วยผ่าตัด	1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5 A
เวลาในการผ่าตัด	≤1.5 ชม.		> 1.5 ≤ 2.5 ชม.		>2.5 ≤ 3.5 ชม.		>3.5 ≤ 4.5 ชม.		>4.5 ชม.	
NHPP	4.3	5.3	8.0	10	12.5	15.5	15.5	19.5	21	26

การคำนวณ Productivity

$$P = \frac{\text{Required staff hours} \times 100}{\text{Actual staff hours}}$$

$$= \frac{\text{ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดใน 1 วัน} \times 100}{\text{ชั่วโมงการพยาบาลของบุคลากรทั้งหมดใน 1 วัน}}$$

The Complex surgery required

- Two setups
- a large number of laboratory test and blood requests to be completed and sent because of the patient's acuity (ASA class ≥3)
- Many pre-prep nursing activities
- Complicated sponge, sharps, and instrument counts
- Complex equipment
- Demanding surgeons and anesthesia professionals

AORN, 2018

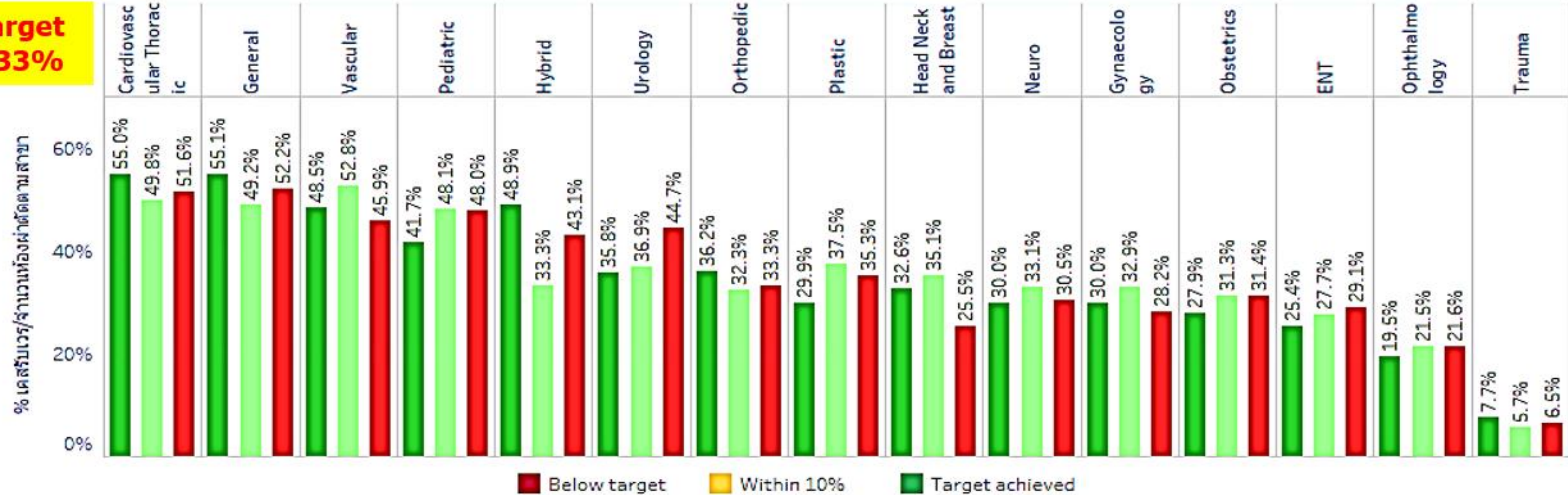
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	แบบเก็บรวบรวมภาระงาน ประจำเดือน มิถุนายน พศ.2568																							
2	หน่วย												งานการพยาบาลผ่าตัด											
3	วันที่	ประเภทผ่าตัด										จน.บุคลากรขึ้นปฏิบัติงาน				ประชุม(ชม.)		ดูงานฯ(ชม)		ภาระงาน/วัน	ควรมี/วัน	มีจริง/วัน	ขาด/วัน	Productivity
4		1	1A	2	2A	3	3A	4	4A	5	5A	RN(คน)	PN(คน)	RN(ชม.)	PN(ชม.)	RN	PN	RN	PN	(ชม.)	(คน)	(คน)	(คน)	(ร้อยละ)
5	พ4	6	0	0	2	1	4	0	3	0	2	20	10	4	0	17	6	7	0	230.80	32.97	26.29	-6.69	125.43
6	พ5	2	4	1	5	0	2	0	1	0	2	21	10	0	0	17	6	14	7	190.30	27.19	24.71	-2.47	110.00
7	ศ6	7	4	2	4	0	2	0	3	0	0	21	9	0	5	0	0	0	0	196.80	28.11	30.71	2.60	91.53
8	จ9	3	0	0	4	0	4	0	2	0	1	21	10	0	0	0	0	0	0	179.90	25.70	31.00	5.30	82.90
9	อ10	0	1	1	4	0	1	0	2	0	3	20	10	0	0	8	8	28	0	185.80	26.54	23.71	-2.83	111.93
10	พ11	2	3	2	3	0	2	0	0	0	3	18	10	0	0	0	0	14	7	179.50	25.64	25.00	-0.64	102.57
11	พ12	2	6	2	6	0	0	0	1	0	1	19	10	0	0	3	0	0	0	161.90	23.13	28.57	5.44	80.95
12	ศ13	3	3	1	6	0	2	0	1	0	2	19	8	0	5	9	6	14	0	199.30	28.47	23.57	-4.90	120.79
13	จ16	1	2	1	8	1	3	0	1	0	1	21	8	0	0	0	0	7	0	207.40	29.63	28.00	-1.63	105.82
14	อ17	1	2	0	5	1	2	0	2	0	3	20	10	0	0	0	0	28	7	225.40	32.20	25.00	-7.20	128.80
15	พ18	4	0	1	1	2	1	1	0	0	3	15	10	0	0	1	0	7	0	169.20	24.17	23.86	-0.31	101.32
16	พ19	1	3	0	7	0	4	0	1	0	0	18	10	0	0	0	0	0	0	171.70	24.53	28.00	3.47	87.60
17	ศ20	1	5	1	3	2	3	0	2	0	1	21	9	0	0	9	0	0	7	205.30	29.33	27.71	-1.61	105.82
18	จ23	1	4	2	3	0	4	1	1	0	2	21	9	0	0	0	0	0	0	220.50	31.50	30.00	-1.50	105.00
19	อ24	1	3	0	2	0	6	0	1	0	2	20	10	5	0	3	0	14	7	204.70	29.24	27.29	-1.96	107.17
20	พ25	2	1	3	5	0	3	0	3	0	2	21	8	0	4	8	0	21	0	244.90	34.99	25.43	-9.56	137.58
21	พ26	2	4	0	6	2	2	0	1	0	1	21	10	0	0	3	8	0	0	191.30	27.33	29.43	2.10	92.86
22	ศ27	0	2	3	5	0	4	0	1	0	2	19	9	0	0	0	0	14	7	218.10	31.16	25.00	-6.16	124.63
23	จ30	0	2	3	6	0	5	0	2	0	1	21	10	0	0	0	0	7	0	237.10	33.87	30.00	-3.87	112.90
24	เฉลี่ย	2.1	2.6	1.2	4.5	0.5	2.8	0.1	1.5	0	1.7	19.8421	9.474	0.474	0.737	4.11	1.79	9.2105	2.21	201.04737	33.51	27.02	-6.49	106.32

อัตราผู้ป่วยรับเวรต่อห้องที่เปิดผ่าตัดในวันทำการ แยกสาขา (ปี)

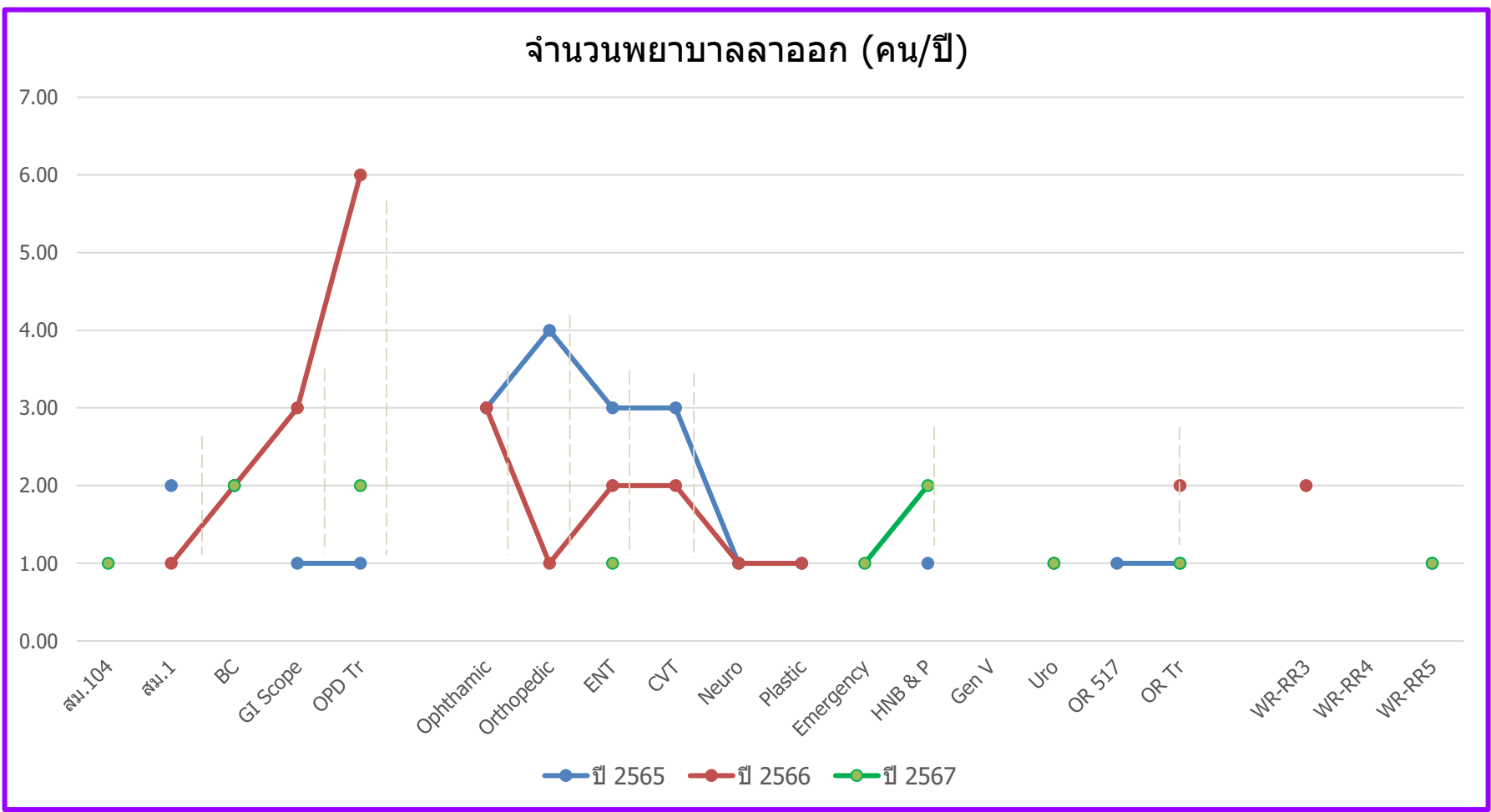
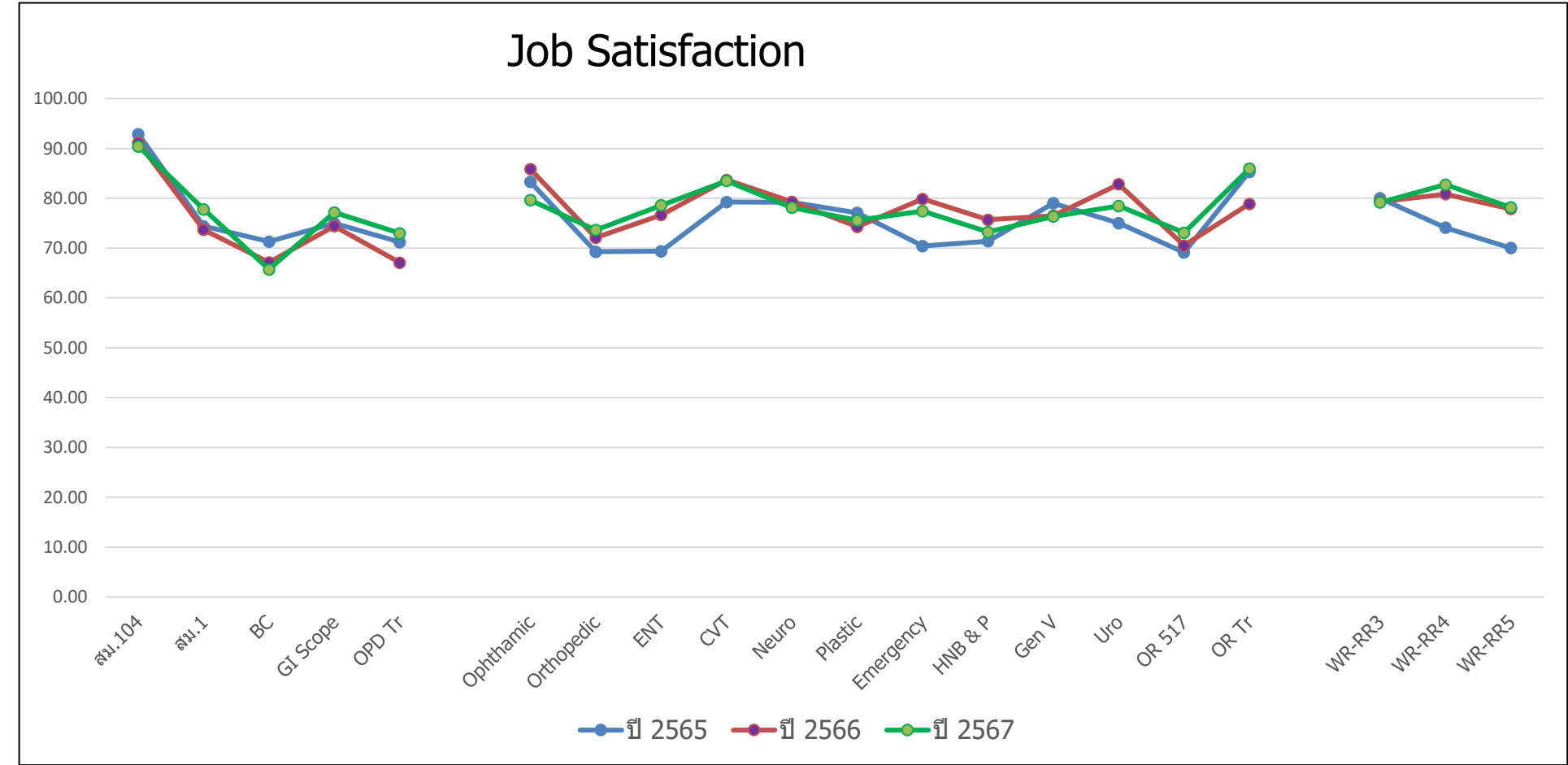
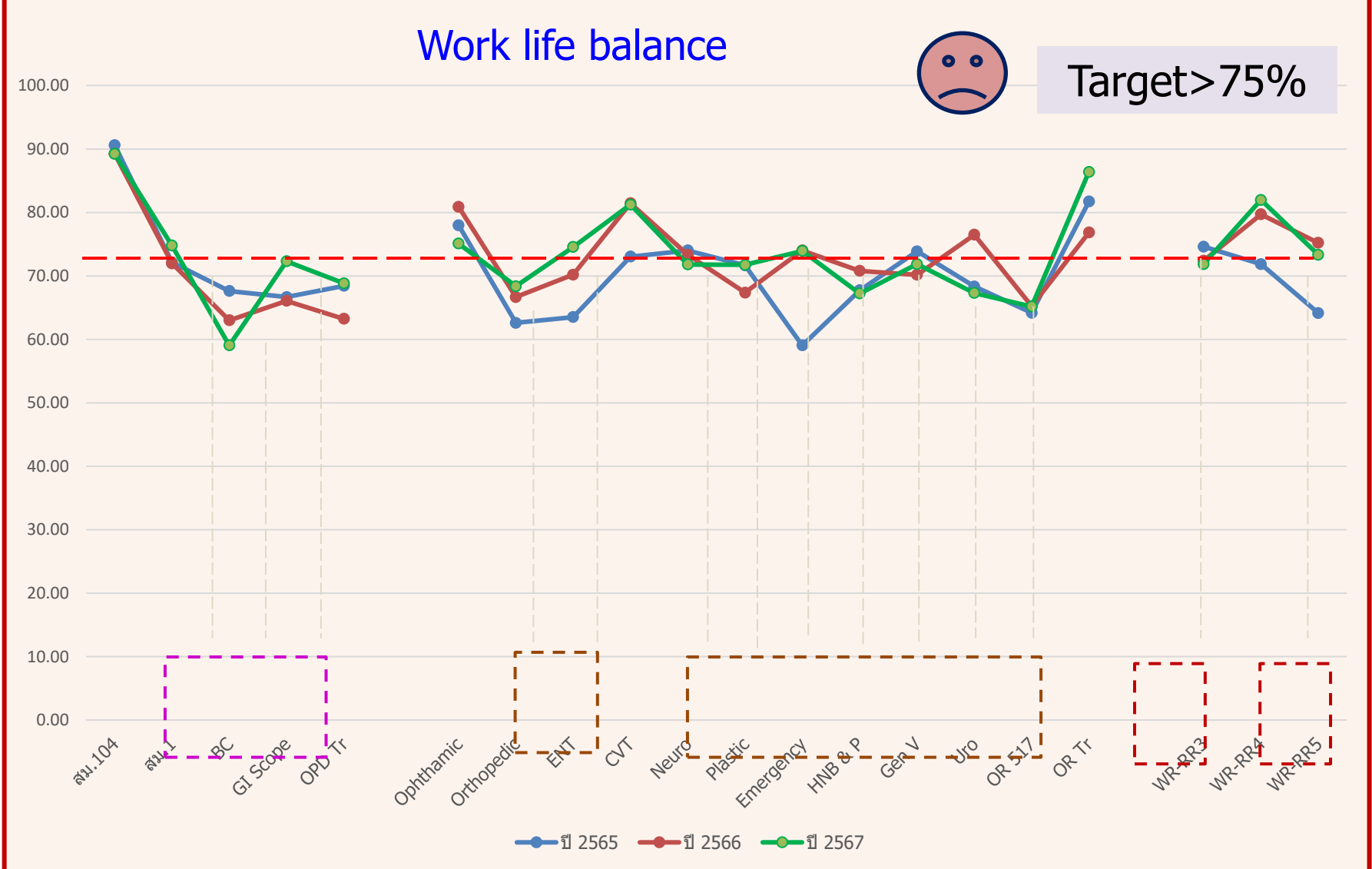
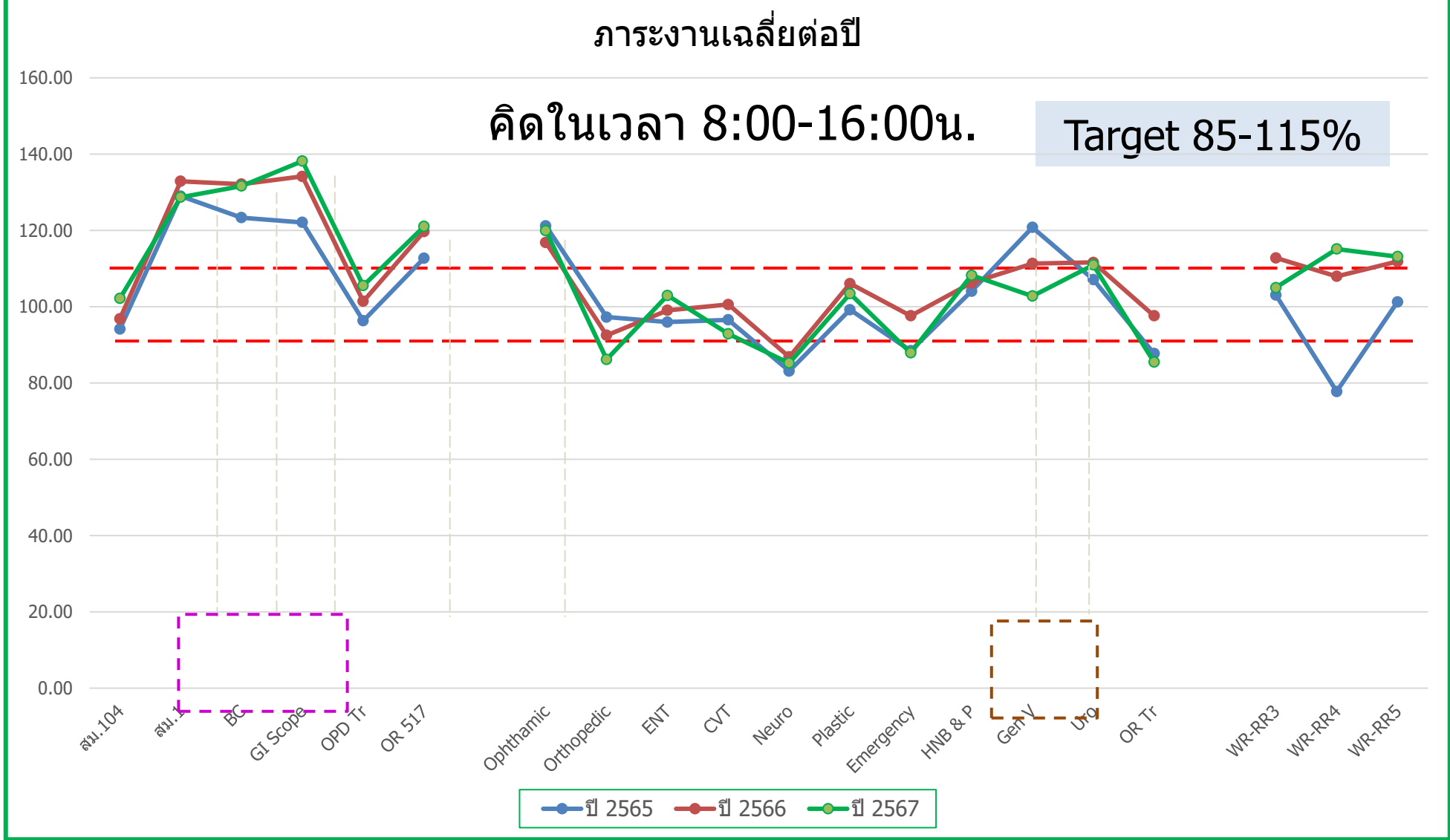
■ 2565 ■ 2567
■ 2566



**Target
<33%**



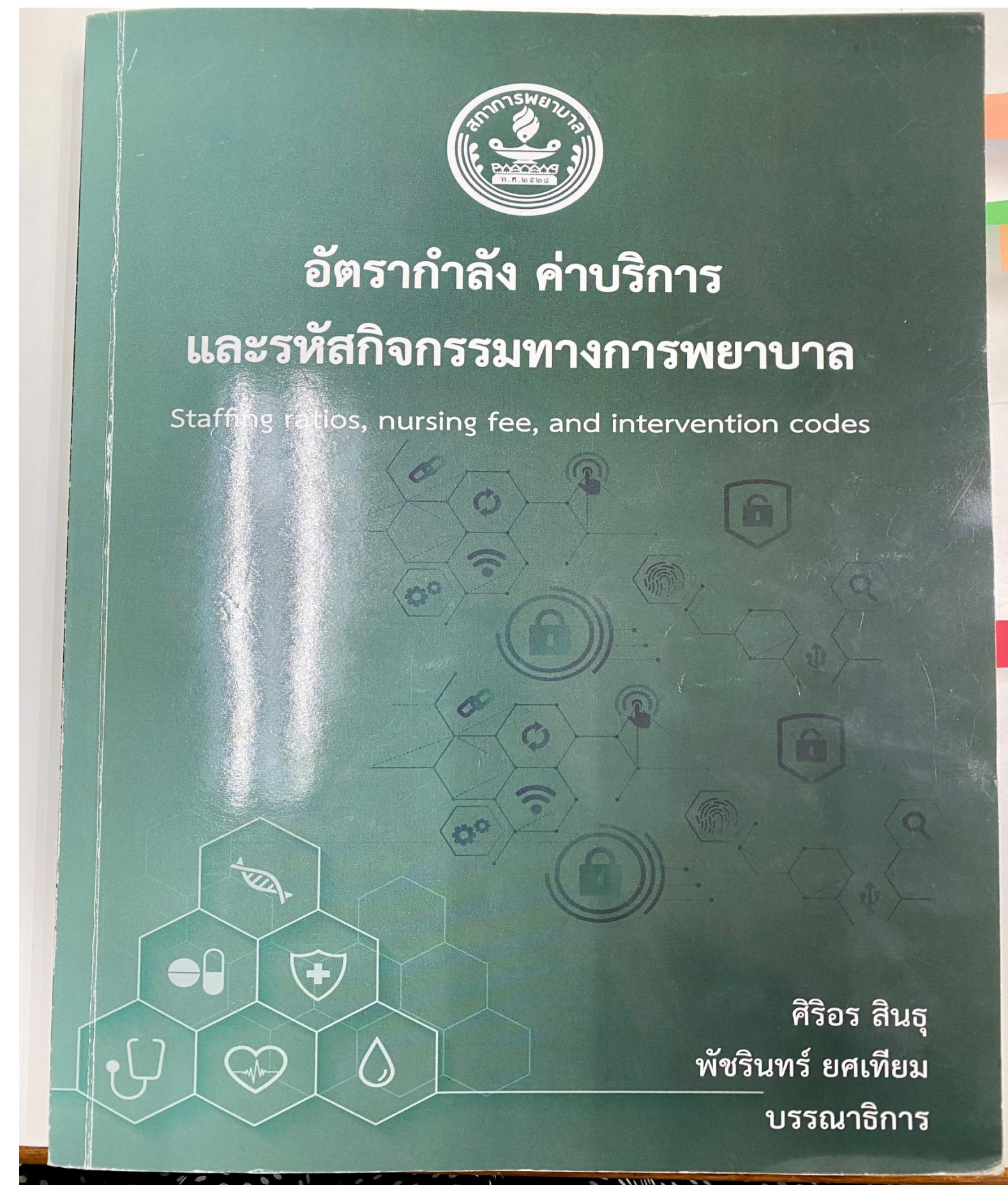
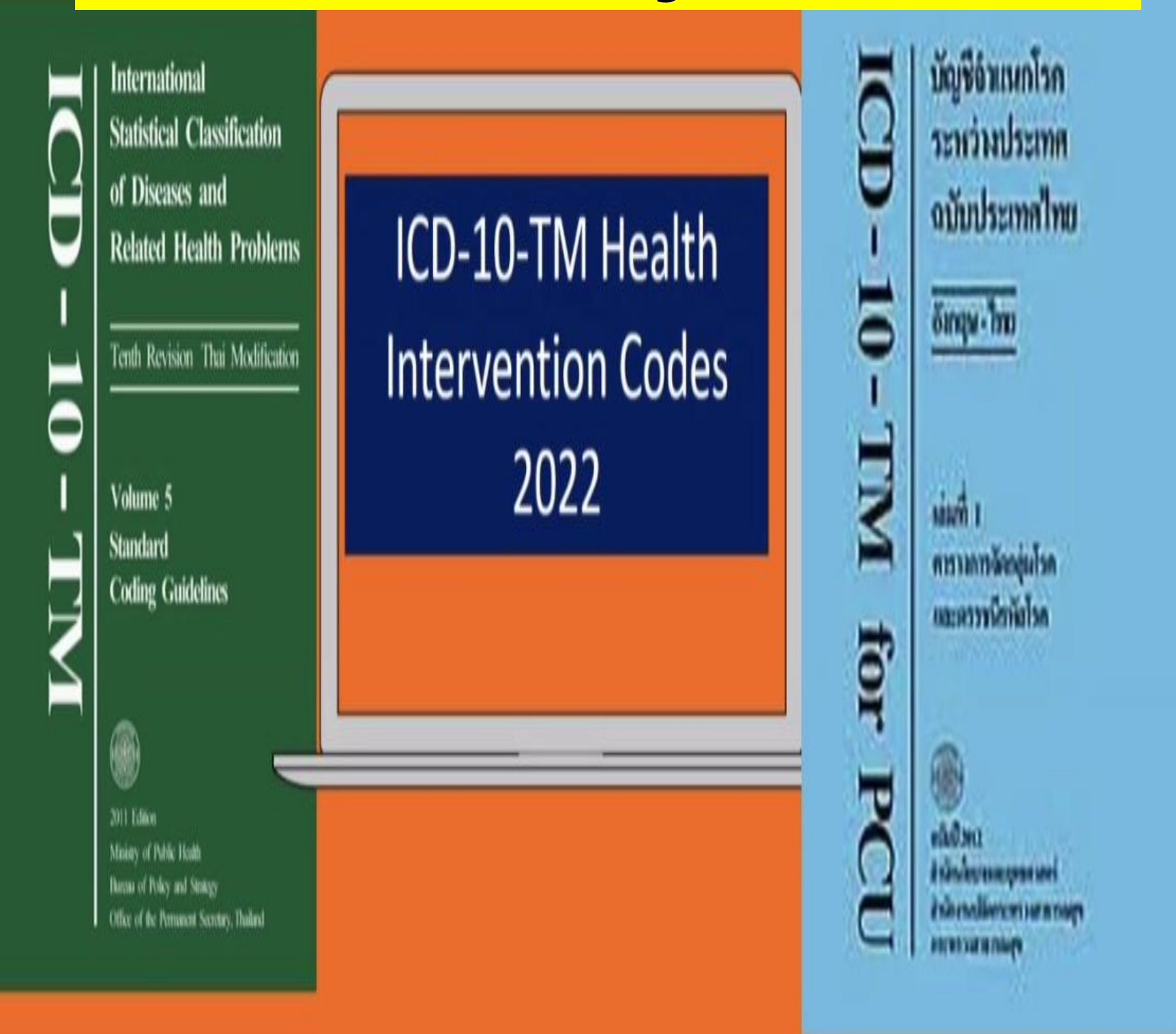
	Cardiovascular Thoracic	General	Vascular	Pediatric	Hybrid	Urology	Orthopedic	Plastic	Head Neck and Breast	Neuro	Gynaecology	Obstetrics	ENT	Ophthalmology	Trauma
2565	55.0%	55.1%	48.5%	41.7%	48.9%	35.8%	36.2%	29.9%	32.6%	30.0%	30.0%	27.9%	25.4%	19.5%	7.7%
2566	49.8%	49.2%	52.8%	48.1%	33.3%	36.9%	32.3%	37.5%	35.1%	33.1%	32.9%	31.3%	27.7%	21.5%	5.7%
2567	51.6%	52.2%	45.9%	48.0%	43.1%	44.7%	33.3%	35.3%	25.5%	30.5%	28.2%	31.4%	29.1%	21.6%	6.5%



ระบบบันทึกการบริการพยาบาลมิติใหม่

อัตรากำลัง รหัสกิจกรรม และค่าบริการการพยาบาล

ICNP → ICD-10TM Nursing Intervention





การพยาบาลในห้องผ่าตัด

การผ่าตัดเล็ก (Minor surgery)	การผ่าตัดใหญ่ (Major surgery)	การผ่าตัดใหญ่เฉพาะทาง (Special major surgery)
4.81 ชั่วโมง หรือ 288.6 นาที	8.64 ชั่วโมง หรือ 518.40 นาที	12.53 ชั่วโมง หรือ 751.8 นาที
สัดส่วน RN: Pt. = 1.5:1	สัดส่วน RN: Pt. = 2.5:1	สัดส่วน RN: Pt. = 4:1
รหัส ICD-10 TM กิจกรรมการพยาบาล		
1. (012-01-00) ประเมินความพร้อมผู้ป่วยในการทำผ่าตัด	1. (012-01-00) ประเมินความพร้อมของการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัด	1. (012-01-00) ประเมินความพร้อมของการเตรียมผู้ป่วยผ่าตัด
2. (012-01-02) เตรียมเครื่องมือผ่าตัดปลอดเชื้อ และบริเวณปลอดเชื้อร่วมกับพยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด	2. (012-01-02) เตรียมเครื่องมือผ่าตัดปลอดเชื้อ	2. (012-01-02) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับท่านอนตะแคง (lateral decubitus) ??
3. (012-02-01) การพยาบาลระหว่างการทำหัตถการ/ผ่าตัด - ...	3. (012-02-01) การพยาบาลระหว่างการทำผ่าตัด - ...	3. (012-02-01) การพยาบาลระหว่างการทำหัตถการ/ผ่าตัด - ...
	(012-02-00) ให้การพยาบาลเพื่อผู้ป่วยปลอดภัยจากการได้รับยาระงับความรู้สึก	



การช่วยแพทย์ผ่าตัด (First Surgeon Assistant)

การช่วยแพทย์ผ่าตัดใหญ่ (major surgery)	การช่วยแพทย์ผ่าตัดใหญ่เฉพาะทาง (Special major surgery)
2 ชั่วโมง หรือ 120 นาที	6 ชั่วโมง หรือ 360 นาที
สัดส่วน RN: Pt. =1:1	สัดส่วน RN: Pt. =1:1
รหัส ICD-10 TM กิจกรรมการพยาบาล	
1. (012-01-00) ประเมินความพร้อมผู้ป่วยในการทำผ่าตัด	1. (012-01-00) ประเมินความพร้อมผู้ป่วยในการทำผ่าตัด
2.(012-01-00) การทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด	2.(012-01-00) การทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะผ่าตัด
3. (012-02-02) การช่วยผ่าตัด	3. (012-02-02) การช่วยผ่าตัด

Transition Program



Level 1

Level 2

Level 3

Level 4

Level 5

Level 6

New nurse

Clinical nurse Specialist

Nurse leader

Key Competency

1. Confident (Standard of nursing practice)
2. Knowledgeable
3. Safety
4. Timely

Key Competency

1. Critical thinking
2. Clinical decision making
3. Prioritization of patient care
4. Organizational skills
5. Leadership
6. Multidisciplinary teamwork

Key Competency

1. Strong ethic
2. Conceptualist thinking
3. Direction setting
4. Management (Strategic, Change, Time, Conflict, data, ...)
5. Multidisciplinary cooperation

8 Nursing skill areas

1. **Behavior conducive to learning**
2. Efficient & effective communication
3. **Personal care** (assessment, planning, evaluation of care using comprehensive nursing models)
4. Documentation
5. Preventing risk & promoting patient safety
6. **Privacy & dignity**
7. **Professional nursing behaviors**
8. Therapeutic nursing behavior

6 Nursing skill areas

1. Exemplary professional practice
2. Specific Preventing risk & promoting patient safety
3. Nursing quality Improvement
4. New knowledge Innovation
5. Mentor/ Clinical Supervision / Educator
6. Inter professional cooperation

5 Nursing skill areas

1. Organization Management
- Quality & Safety & healthy
2. Empirical Quality result
3. Nursing Professional development
4. Relationships and partnerships management
5. Entrepreneur

Learning Style

Single Educational institution

Learning Style

Inter Professional Practice/Activity

Learning Style

International Network Training



Nursing Leadership Development Strategy

Build Leadership for All levels

Goal

Expected Performance



Knowledge evaluation

- ❖ Examination
 - MCQ (Multiple choice question)
 - OSCE (Objective Structured Clinical Examination)

Skills evaluation

- ❖ Observation
- ❖ Scenario testing



EPA (Entrustable Professional Activity)

Level 1: Able to observe only (cannot perform independently)

Level 2: Able to perform under close supervision and guidance.

Level 3: Able to perform under indirect supervision, with assistance available if needed

Level 4: Able to perform independently, with supervision available for consultation

Level 5: Able to perform independently with excellence, can supervise and train others



การพัฒนาวิชาชีพ การพยาบาลปริศัลยกรรม Partnership & Networking

หลักสูตร Post Baccalaureate Residency Training Program สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 3 ปี สำหรับพยาบาลจบใหม่

- 1) รพ.ศิริราช
- 2) รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
- 3) รพ.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม 4 เดือน

- 1) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล & รพ.ศิริราช (สค.-พย.)
- 2) งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด รพ.ราชวิถี & วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (กพ.-พค.)
- 3) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี & สรรพสิทธิประสงค์ (กพ.-พค.) เปิดรุ่นที่ 1 ปี 2567
- 4) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี & รพ.ศรีสะเกษ รพ.สกลนคร และรพ.สมเด็จพระยุพราชเดชอุดม (กพ.-พค.) เปิดรุ่นที่ 1 ปี 2567
- 5) วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี & รพ.พระปกเกล้า จันทบุรีเปิดรุ่นที่ 1 ปี 2568
- 6) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ & รพ.สงขลานครินทร์ (กำลังขออนุมัติเปิด)



เข้าพิจารณาในคณะกสภาการพยาบาลวันที่ 20มค68



(ร่าง) ข้อบังคับสภาการพยาบาล
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองวิทยฐานะพยาบาลเฉพาะทาง
พ.ศ. ...

หมวด ๑
สาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสือรับรองวิทยฐานะ

ข้อ ๔ สภาการพยาบาลอาจออกหนังสือรับรองวิทยฐานะในสาขาการพยาบาลเฉพาะทาง หรือ อนุสาขาต่างๆ ดังนี้

(๑) สาขาที่ออกหนังสือรับรองวิทยฐานะ

(๑.๑) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

(๑.๒) การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด

(๑.๓) การพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

(๑.๔) การบริหารการพยาบาล

(๑.๕) การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง

(๑.๖) การพยาบาลปริศัลยกรรม

(๑.๗) การพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

(๑.๘) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

(๑.๙) การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล/การสอนการพยาบาลในคลินิก

(๒) อนุสาขาที่ออกหนังสือรับรองวิทยฐานะ

(๒.๑) การพยาบาลผู้ป่วยออสโตมีและแผล

(๒.๒) การพยาบาลผู้ป่วยเคมีบำบัด

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสาขาและอนุสาขา การเพิ่ม หรือ ลดสาขาและอนุสาขาที่ออกหนังสือรับรอง วิทยฐานะ ให้ออกเป็นประกาศของสภาการพยาบาล



ระบบการจัดการเวชภัณฑ์ Siriraj Medical Supply: SiMS



จำนวนผู้ใช้งาน : 356383

Siriraj Medical Supply(SiMS)

- บันทึกการยืม
- บันทึกการยืมระหว่างหน่วยงาน
- ตรวจสอบการจ่าย/คืน
- รายงาน

- ♥ รายงานตรวจสอบนับ Stock 1
- ♥ รายงานตรวจสอบนับ Stock 2
- ♥ รายงานที่ไม่ได้ส่งคืนอุปกรณ์ผ่าตัด
- ♥ รายงานการใช้อุปกรณ์/เวชภัณฑ์

**SIRIRAJ**
MEDICAL SUPPLY(SiMS)

Home [| [ออกจากระบบ](#)]

บันทึกข้อมูลการยืม

เลขที่ :

HN : 38164510 ชื่อผู้ป่วย : Admission date : 6/12/2014

AN : เลขบัตรประชาชน : อายุ : 89

สิทธิการรักษาพยาบาล : ☒ กรมบัญชีกลาง (เบิกจ่ายตรง) ☐ ประกันสังคม ☐ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ☐ อื่นๆ

หน่วยงาน : ห้อง :

เลือกชุดอุปกรณ์ :

#	รหัส กบค.	รหัสสั่ง	SIMSGroup	SAPCODE	รายการ	ราคา (บาท)/ชิ้น	ราคาเบิกได้	จำนวนที่ยืม	การเบิก
No data to display									

Add แสดง SIMSGroup

รหัส SAP ผู้รับของ :

Save Clear



[Home](#)

[| [ออกจากระบบ](#)]

บันทึกข้อมูลการยืม

เลขที่ :

HN : 38164510



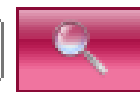
ชื่อผู้ป่วย :

นาง

Admission date : 6/12/2014

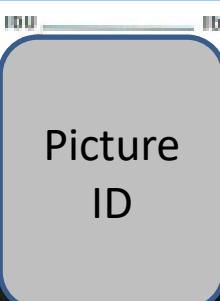


AN :



เลขบัตรประช. :

อายุ : 89



สิทธิการรักษาพยาบาล :

☒ กรมบัญชีกลาง (เบิกจ่ายตรง) ☐ ประกันสังคม ☐ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ☐ อื่นๆ

หน่วยงาน : ศัลยศาสตร์ - หน่วยผ่าตัดศัลยศาสตร์ตกแต่ง สยามิ

ห้อง : 417plastic

เลือกชุดอุปกรณ์ : ---select---

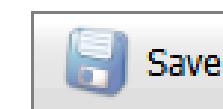
- select---
- Plastic1
- LVA
- Free Flap
- STSG



#	รหัส กบค.	รหัส	ราคา (บาท)/ชิ้น	ราคาเบิกได้	จำนวนที่ยืม	การเบิก
No data to display						

แสดง
SiMSGGroup

รหัส SAP ผู้รับของ :

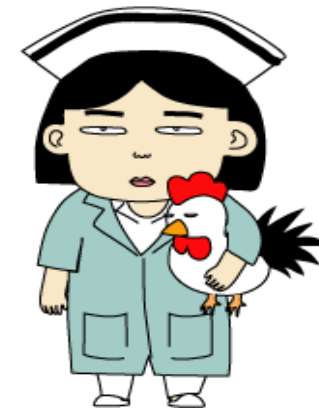


Future Challenges



การสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเผยแพร่สู่วงการพยาบาลปริศลยกรรมนานาชาติ

การเตรียมอัตรากำลัง ระดับผู้นำ
สำหรับการขยายงานบริการห้องผ่าตัด



สร้างเครือข่ายระดับนานาชาติ



Networking



Collaboration



25..?

ทัศนียภาพโครงการ
แบบผู้นำโครงการ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
งานแก้ไขงาน โครงการอาคารรักษาพยาบาล และสถานีศิริราช
ทัศนียภาพภายนอกและภายในโครงการ 17 กุมภาพันธ์ 2564 103i



2575?

โครงการสถาบันการแพทย์ศิริราช
ระดับนานาชาติ (พื้นที่บางโพ)



Future

1

Innovation & Technology



2

Role & Responsibility of Nurse



3

Direction & Challenges



Pathway to Sustainability

- Created balance between Safety-Science-Soul
 - Nurse as a Validator and Ethical Gatekeeper
- Green OR

Workforce Shortage & Aging Staff

- Using technology and other profession to replace some jobs
- Electronic Self Training & Competency-based Training
 - : AR/ VR Training, simulation center



- **Knowledge Navigator**: Care Manager, Coordinator, Educator, Researcher, Informatic nurse
- **Personalized Perioperative Care**:
 - Identified case-specific risk factors to minimize complications during surgery
- **Data-driven Nursing**: Utilizes clinical outcome for quality improvement of care

Implications of Advanced Surgical Technologies

- Clinical practice?
- **Smart OR & Digital OR & OR Black Box**
 - OR Management

Direction & Challenges: Pathway to Sustainability

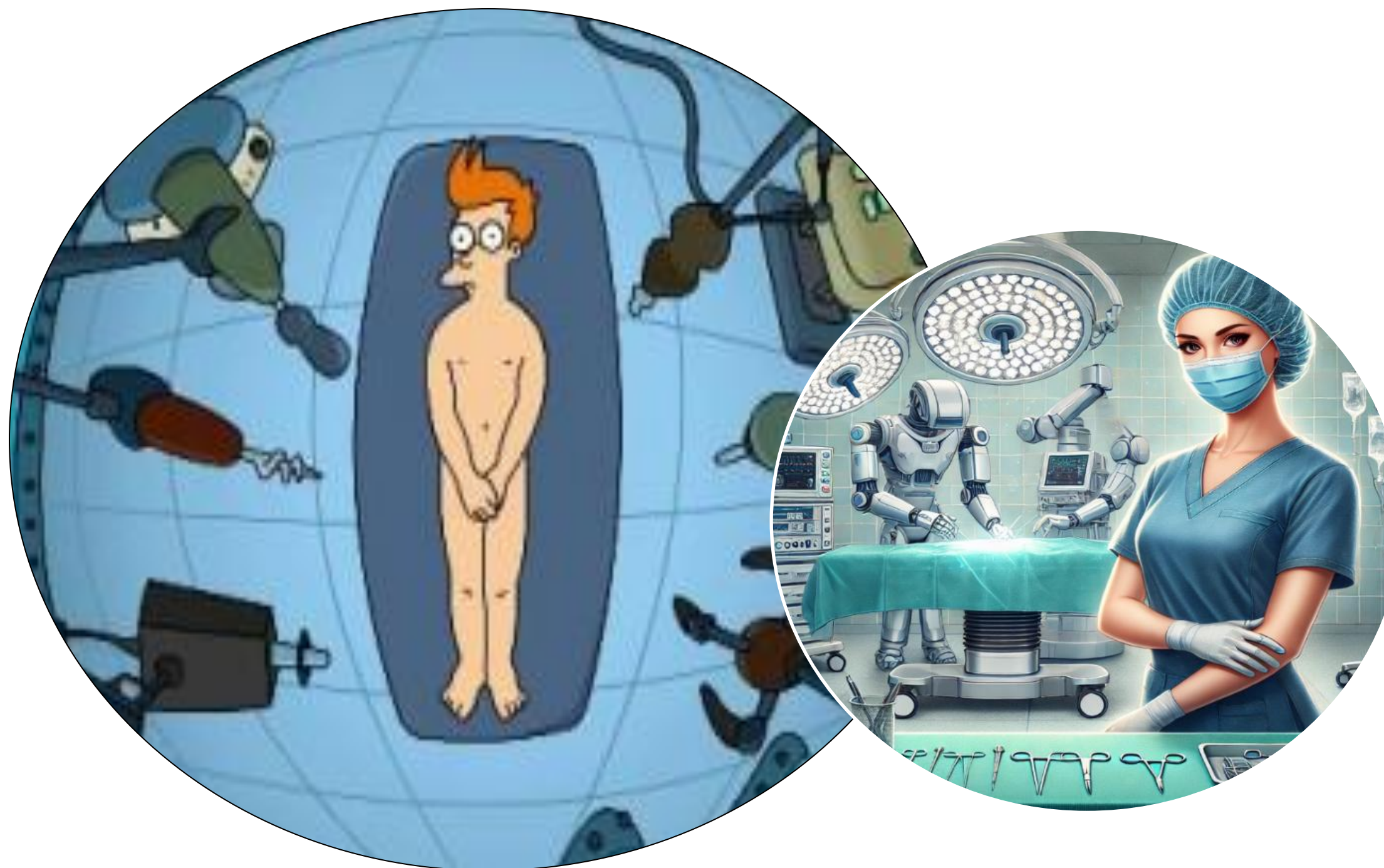


- ❖ Created balance between **Safety-Science-Soul**
- ❖ Upskilling in data management, workflow integration, AI literacy
- ❖ AI-enhanced workflow with Human in the loop
- ❖ Research and innovation in collaboration with networks





พยาบาลคือ "ผู้รักษาความหมายของการผ่าตัด" ไม่ใช่เพียงผู้ช่วยเหลือ
พยาบาลเป็น **bridge** ระหว่างศัลยแพทย์ – ทีมวิสัญญี – ทีมสุขภาพอื่นๆ และทีมสนับสนุน



Thank You for Your Attention